Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Ciencias de la Salud

Trauma del Desarrollo como Predictor Transdiagnóstico de Psicopatología: un Análisis Multivariante.

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Trabajo fin de estudio presentado por:	Pablo Pérez Vargas
Tipo de trabajo:	Proyecto de investigación
Línea de investigación:	Línea de investigación 1. Prevención e intervención temprana en trastornos psicopatológicos. Línea de investigación 6. Evaluación y psicodiagnóstico en psicología general sanitaria.
Formato de trabajo:	Individual
Modalidad de TFE:	Proyecto de investigación
Director/a:	Pedro Carlos Martínez Suarez
Fecha:	15/10/2025

Resumen

La clasificación categorial tradicional a menudo fragmenta la realidad clínica del trauma del desarrollo. Este estudio adopta un enfoque transdiagnóstico para analizar la relación entre experiencias adversas tempranas y psicopatología adulta en una muestra de 90 participantes.

Mediante Análisis de Componentes Principales, Biplot y Clústeres (*K-Means*), se identificó una estructura latente de vulnerabilidad generalizada (*Factor* p) donde el trauma emocional y la desregulación afectiva convergen en un continuo de severidad, trascendiendo las etiquetas diagnósticas rígidas de ansiedad y depresión. Se hallaron dos perfiles clínicos polarizados (vulnerable vs. adaptativo), cuya diferenciación no dependió de variables sociodemográficas estructurales, sino de la solidez del apoyo social y, notablemente, de la estabilidad de los ritmos vitales (jornada laboral). Los hallazgos cuestionan la rigidez nosológica actual y sugieren priorizar intervenciones *bottom-up* centradas en la estabilización de los ritmos sociales (*zeitgebers*) para mitigar la carga alostática del trauma complejo.

Palabras clave: Trauma del desarrollo, sintomatología afectiva, enfoque transdiagnóstico, Biplot, Factor p.

Abstract

Traditional categorical classification often fragments the clinical reality of developmental trauma. This study adopts a transdiagnostic approach to analyse de relationship between early adverse experiences and adult psychopathology in a sample of 90 participants. Using Principal Component Analysis, Biplot and K-Means Clustering, a latent structure of generalized vulnerability (*p Factor*) was identified, where emotional trauma and affective dysregulation converge on a severity continuum, transcending rigid anxiety and depression labels. Two polarized clinical profiles (vulnerable vs. adaptive) were found; their differentiation did not depend on structural sociodemographic variables but on the strength of social support and, notably, the stability of vital rhythms (work schedule). These findings question current nosological rigidity and suggest prioritizing *bottom-up* interventions focused on stabilizing social rhythms (*zeitgebers*) to mitigate the allostatic load of complex trauma.

Keywords: Developmental trauma, affective symptomatology, transdiagnostic approach, Biplot, *p* Factor.

Índice de contenidos

1. Marco teórico 8
1.1. Bases neurobiológicas y psicofisiológicas del trauma infantil. 9
1.1.1. La amígdala. 10
1.1.2. El hipocampo 10
1.1.3. El eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HPA). 10
1.1.4. La corteza prefrontal (CPF). 11
1.1.5. Corteza cingulada anterior (CCA) 11
1.1.6. La ínsula. 11
1.1.7. El tálamo 12
1.1.8. Integración de la evidencia neurobiológica. 12
1.2. Trauma del desarrollo y estrategias de supervivencia. 12
1.3. Del trauma infantil a las manifestaciones psicológicas adultas. 13
1.3.1. Síntomas afectivo-emocionales. 14
1.3.2. Síntomas cognitivos. 14
1.3.3. Síntomas conductuales. 15
1.4. Más allá de los diagnósticos convencionales: hacia un enfoque transdiagnóstico del trauma. 17
2. Justificación 19
3. Objetivos 20
3.1. Objetivo principal 20
3.2. Objetivos secundarios 20
4. Hipótesis 21
5. Marco metodológico 22
5.1. Diseño 22

5.2. Participantes 22
5.3. Instrumentos 22
5.4. Procedimiento 24
5.5. Análisis de datos 24
6. Resultados 25
6.1. Caracterización sociodemográfica de la muestra. 25
6.2. Propiedades psicométricas y estadísticos descriptivos de las variables clínicas. 28
6.3. Análisis de la estructura latente: distribución y contribución de las variables 29
6.4. Verificación de supuestos y estructura dimensional (PCA) 32
6.5. Evaluación del agrupamiento y determinación del número de perfiles 35
6.6. Configuración espacial y caracterización clínica de los perfiles latentes. 36
7. Discusión 41
7.1. Limitaciones 44
7.2. Prospectiva 45
Referencias bibliográficas 47

Índice de figuras

Figura 1. *Distribución de las puntuaciones en las subescalas del CTQ-SF*..... 30

Figura 2. *Contribución de cada subescala a la Componente Principal 1.*..... 31

Figura 3. *Contribución de cada subescala a la Componente Principal 2.*..... 32

Figura 4. *Biplot: Representación simultánea de las variables (vectores) y los sujetos (puntuaciones individuales) sobre las dos primeras componentes principales.*..... 34

Figura 5. *Representación gráfica del método de la silueta.* 36

Figura 6. *Proyección espacial de los dos clústeres sobre las dos primeras componentes principales, con elipses de confianza al 95% alrededor de los centroides.* 37

Índice de tablas

Tabla 1. *Características sociodemográficas y contextuales de la muestra* 26

Tabla 2. *Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas del estudio* 29

Tabla 3. *Comparación de variables clínicas y de trauma entre los perfiles clínicos.* 38

Tabla 4. *Comparación sociodemográfica entre los perfiles clínicos.* 40

1. Marco teórico

La clasificación de los trastornos mentales ha sido históricamente un desafío central en psicología clínica y psiquiatría. Ante la necesidad de ordenar y explicar la realidad con las herramientas disponibles, se ha construido un mapa – hegemonizado por el DSM – sobre el que se ha seguido edificando durante décadas con la intención de perfeccionar su precisión. Si bien la utilidad clínica y la estandarización del diagnóstico logradas por el DSM han supuesto avances incuestionables, existe la creciente sospecha de que, a pesar de los esfuerzos por refinar el mapa, este no logra reflejar fielmente el territorio.

El sesgo de persistir en el ajuste de un modelo que, de base, quizás no sea el adecuado para capturar la naturaleza fluida del sufrimiento humano, evoca inevitablemente la figura mitológica de Procusto: aquel posadero que, en lugar de adaptar la cama al viajero, mutilaba o estiraba sus extremidades para obligarlos a encajar, a cualquier precio, en su lecho de hierro.

La pertinencia de esta analogía ha sido señalada tanto por críticos teóricos como por los propios artífices del sistema. Mientras que Eysenck (1995) advertía que "ningún esfuerzo humano tendría éxito al intentar forzar la compleja realidad psicopatológica en este *lecho de Procusto*", el propio Allen Frances —presidente del grupo de trabajo del DSM-IV— admitía que el diagnóstico categorial funcionaba como tal al intentar tipificar un continuo carente de límites claros (Frances, 1993). No obstante, Frances limitó esta crítica al ámbito de la personalidad, manteniendo una postura más pragmática y conservadora respecto al resto de la psicopatología, donde defendía la utilidad clínica de las categorías diagnósticas pese a sus imperfecciones.

Esta tensión entre la rigidez de los modelos y la naturaleza fluida de la psicopatología parece cobrar una mayor relevancia en el estudio de la adversidad temprana. En este ámbito, la evolución del concepto de trauma refleja precisamente ese tránsito hacia un enfoque más integrador: mientras que durante décadas el foco se ha situado principalmente en los eventos traumáticos —es decir, aquellos acontecimientos externos como guerras, abusos, desastres o pérdidas—, la comprensión actual ha evolucionado hacia una visión más compleja y dinámica, reconociendo que incluso experiencias cotidianas, aunque menos visibles, pueden tener efectos profundos en la mente y el cuerpo.

El concepto de *trauma* hace referencia a las consecuencias psicológicas derivadas de la exposición a experiencias que amenazan la supervivencia o el bienestar personal. No obstante, la naturaleza del trauma puede variar en función del tipo de estresor implicado. Allen, Fonagy y Bateman (2008), citados en Cervera Pérez et al. (2020), proponen una clasificación que distingue entre estresores impersonales —como desastres naturales o accidentes—, interpersonales —cuando el daño procede de la acción intencionada de otro ser humano—, y aquellos que ocurren en el contexto de las relaciones de apego —como el maltrato físico o emocional, el abuso sexual o la negligencia—. Esta última categoría resulta especialmente relevante en el estudio del trauma temprano, dado que compromete los vínculos fundamentales de seguridad y regulación afectiva sobre los que se construye el desarrollo psicológico.

Guerrero Velázquez (2024) enfatiza que el trauma no se define por lo que ocurre, sino por cómo el individuo lo percibe, lo procesa y responde ante ello. En esta línea, el trauma se concibe como una respuesta psicobiológica desbordada frente a una amenaza que supera la capacidad de integración de la persona.

Bessel van der Kolk (2014) amplía esta perspectiva al demostrar que las experiencias traumáticas dejan una huella profunda no solo en la mente, sino también en el cuerpo y en el cerebro. Según su enfoque, el trauma altera los sistemas neurobiológicos encargados de la percepción, la emoción y la memoria, provocando una activación constante del sistema de alerta y dificultando la integración de la experiencia. Como señala en su obra *El cuerpo lleva la cuenta*, las huellas del trauma permanecen registradas en las respuestas fisiológicas incluso cuando la mente intenta olvidarlas. Esta desconexión entre la experiencia corporal y la conciencia genera síntomas persistentes como hipervigilancia, disociación, inatención o falta de sensibilidad emocional, que reflejan la dificultad del organismo para sentirse verdaderamente seguro.

1.1. Bases neurobiológicas y psicofisiológicas del trauma infantil.

El trauma psicológico infantil, conocido como Estrés Temprano en la Vida (ELS, *Early Life Stress*), deja una huella neurobiológica profunda. Esta se ve intensificada por la naturaleza inmadura del sistema nervioso, que se caracteriza por una elevada excitabilidad y una falta de conexiones inhibitorias. Estas alteraciones tempranas desvían las trayectorias de desarrollo

normales en estructuras cruciales para la emoción, la cognición y la homeostasis. A continuación, se describen las estructuras cerebrales más relevantes que muestran cambios asociados al trauma infantil.

1.1.1. La amígdala.

En el núcleo de la respuesta emocional se encuentra la *amígdala*, estructura que permite evaluar rápidamente el peligro para producir una respuesta adecuada al estímulo. Esta área, que se desarrolla rápidamente hasta los 4 años, es particularmente sensible al ELS. El trauma infantil provoca una mayor reactividad bilateral de la amígdala ante estímulos emocionales negativos, como rostros tristes, y dificulta la capacidad de suprimir esta sobreactivación (Campbell, 2022). Esta hiperactivación límbica a menudo se produce antes de que las estructuras corticales más lentas puedan evaluar la información, lo que puede dar lugar a respuestas de emergencia estereotipadas —lucha, huida o paralización— incluso ante estímulos inocuos, complicando el aprendizaje basado en experiencias vitales individuales (van der Kolk, 2003). Asimismo, la severidad de la exposición, como el abuso verbal o físico, se ha asociado con un mayor volumen de la amígdala derecha en la edad adulta (Mehta et al., 2009), lo que podría contribuir a la intensa reactividad emocional observada en personas con antecedentes de trauma infantil.

1.1.2. El hipocampo

Adyacente a la amígdala, el hipocampo es fundamental para la memoria dependiente del contexto y la regulación emocional. Un hallazgo común en adultos con diagnóstico de TEPT es una reducción del volumen general del hipocampo (Logue et al., 2018). Dado que el hipocampo es rico en receptores de glucocorticoides, la exposición crónica a niveles elevados de CRH y cortisol tiene un impacto negativo en la neuroplasticidad (Gunnar & Quevedo, 2007, citado en Campbell, 2022).

1.1.3. El eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HPA).

La disfunción del sistema emocional se coordina con una alteración en el Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HPA), el sistema neuroendocrino central del estrés. El trauma temprano sensibiliza este sistema al aumentar el número y la función de las sinapsis excitatorias en las neuronas sensibles al estrés del hipotálamo (Gunn et al., 2013), lo que aumenta la sensibilidad del cerebro ante situaciones estresantes.

1.1.4. La corteza prefrontal (CPF).

La corteza prefrontal (CPF) es responsable de las funciones ejecutivas superiores, como la planificación y el control de impulsos. La Corteza Prefrontal Medial (CPFM) actúa como la "torre de vigilancia" del cerebro, evaluando la realidad del peligro y ejerciendo un control regulatorio de arriba abajo sobre las emociones (van der Kolk, 2014). Según van der Kolk, el miedo, la tristeza y la rabia intensos causan una reducción de actividad en la CPFM, lo que resulta en que las capacidades inhibidoras fallen y la persona pierda el control sobre sus emociones y sus impulsos. La hipoactividad en la CPFM también dificulta el autoconocimiento y el registro de los estados internos, lo cual es congruente con síntomas de TDAH.

Por otro lado, la Corteza Prefrontal Dorsolateral (CPFDL), que determina el contexto y la percepción del tiempo, se desactiva durante los flashbacks característicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), causando que el individuo pierda la sensación del tiempo y se sienta atrapado en el momento (van der Kolk, 2014).

1.1.5. Corteza cingulada anterior (CCA)

La Corteza Cingulada Anterior (CCA) se encarga de la conciencia de uno mismo, coordina las emociones y el pensamiento y participa en la regulación cognitiva de las emociones. El trauma, especialmente el ELS, se asocia con reducciones volumétricas en la CCA y alteraciones en la materia blanca del cíngulo (van der Kolk, 2014). Esta disfunción contribuye a una disociación y somatización comprometidas y dificulta la inhibición prefrontal de las respuestas de miedo. Asimismo, la reducción de los niveles de GABA en la CCA se asocia con la alteración de la capacidad de inhibición de la respuesta (Santos da Silva, 2023).

1.1.6. La ínsula.

La ínsula es fundamental para la interocepción y la autoconcienciación sensorial, ya que transmite los mensajes de las vísceras y ayuda a generar la sensación corporal. El trauma crónico se asocia con una actividad marcadamente reducida en esta área, junto con otras regiones de la autopercepción. Esta hipoactividad surge como una adaptación que busca desconectar las sensaciones aterradoras. La disfunción insular contribuye a la alexitimia —es decir, la incapacidad de identificar, expresar y procesar las propias emociones— y a la pérdida de la noción de propósito y dirección (van der Kolk, 2014).

1.1.7. El tálamo

El tálamo actúa como el filtro del cerebro, cuya función es integrar toda la información sensorial entrante a través de los sentidos para dar lugar a una experiencia coherente. Es el componente central de la atención y la concentración. Cuando una persona se expone a niveles extremos de estrés, el tálamo se desactiva. Esto explica por qué el trauma se recuerda como fragmentos sensoriales aislados, como imágenes, sonidos y sensaciones físicas, en lugar de una narración lógica con principio y fin (van der Kolk, 2014). En el TEPT, el tálamo no es capaz de filtrar la información irrelevante, lo que resulta en una sobrecarga sensorial constante, que puede dar lugar a síntomas como desconexión y visión de túnel.

1.1.8. Integración de la evidencia neurobiológica.

Estas alteraciones neurobiológicas, desde la hiperactivación límbica hasta la hipoactividad prefrontal y la disfunción en la ínsula y el tálamo, configuran un perfil psicobiológico que puede manifestarse en múltiples dominios de funcionamiento, como atención, regulación emocional y procesamiento cognitivo. Esta evidencia respalda la hipótesis de que distintos síntomas observables en la adultez —propios de la ansiedad, la depresión, el TEPT o el TDAH— pueden compartir raíces comunes en experiencias tempranas de trauma, en lugar de constituir entidades diagnósticas completamente independientes.

1.2. Trauma del desarrollo y estrategias de supervivencia.

El trauma del desarrollo, entendido como la exposición crónica y repetida a experiencias adversas en el contexto de las relaciones de apego tempranas —como maltrato, abuso o negligencia—, condiciona profundamente la arquitectura psicológica del individuo. La infancia, al ser una etapa de alta plasticidad neuronal, es especialmente vulnerable a estas agresiones ambientales, que interfieren con el neurodesarrollo y la maduración cerebral (Amores-Villalba & Mateos-Mateos, 2017). Desde una perspectiva cognitivo-conductual, estas experiencias estresantes alteran los sistemas de autorregulación y la percepción de amenaza, forzando al niño a generar *estrategias de supervivencia* diseñadas para navegar y mitigar un entorno percibido como peligroso e impredecible. Estas respuestas, aunque adaptativas para la supervivencia inmediata, son intentos desesperados por restablecer un sentido de control ante la impotencia y el terror ineludibles.

La manifestación de estas estrategias se codifica en la mente y el cuerpo del niño, creando un esquema cognitivo inflexible sobre la realidad y el yo. Un componente central de estas adaptaciones es la *hipervigilancia*, donde el cerebro se reprograma para estar constantemente alerta ante el peligro (van der Kolk, 2014). Esto se refleja en la tendencia de los niños maltratados a interpretar estímulos neutrales como amenazas, reaccionando con excesiva reactividad. Por ejemplo, la negligencia o falta de sintonía emocional por parte del cuidador pueden llevar al desarrollo de *mecanismos de evitación* (como la distracción o la fantasía) para suprimir sentimientos abrumadores, o, por el contrario, a la agresividad como un intento de autoprotección frente al abuso físico. Este tipo de comportamientos, como el retraimiento, son la expresión de un terror que el niño no es capaz de procesar ni verbalizar, pero que se manifiesta a través de reacciones físicas y conductuales.

1.3. Del trauma infantil a las manifestaciones psicológicas adultas.

El cerebro organiza e internaliza la nueva información de manera *uso-dependiente*, lo que significa que cuanto más se activa un patrón específico de actividad neuronal, más consolidado y duradero se vuelve en su representación interna (Perry et al., 1995).

Las experiencias traumáticas repetidas generan respuestas emocionales y conductuales que, en un principio, deberían ser reacciones temporales ante una situación de amenaza o estrés. Sin embargo, cuando estos episodios se repiten o se prolongan en el tiempo, dichas respuestas se consolidan funcional y estructuralmente como *rasgos* permanentes (Perry et al., 1995), configurando esquemas cognitivos disfuncionales que influyen en la percepción, interpretación y conducta ante la realidad (van der Kolk, 2003).

De este modo, los mecanismos originalmente adaptativos se transforman en disposiciones rígidas que condicionan la experiencia subjetiva y la conducta, provocando que el individuo emita respuestas defensivas o desadaptativas incluso en contextos neutros o no amenazantes.

A largo plazo, estas respuestas adaptativas internalizadas se manifiestan en un conjunto de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales que suelen categorizarse bajo diferentes diagnósticos clínicos, aunque comparten un mismo origen en la exposición temprana al trauma.

1.3.1. Síntomas afectivo-emocionales.

A nivel emocional y afectivo, los adultos que han sufrido trauma temprano suelen presentar graves alteraciones en la *autorregulación afectiva* (Spinazzola et. al., 2005). Esta ineficacia para modular o recuperarse de estados afectivos extremos es el resultado de la sensibilización de los circuitos neurales del miedo, particularmente en el sistema límbico (Perry, 1995).

Como consecuencia, el individuo puede desarrollar una hipervigilancia crónica y una preocupación constante por el peligro inminente (Campbell, 2022), lo que podría reflejar una alta prevalencia de trastornos internalizantes, como depresión y ansiedad, en la edad adulta (Humphreys et al., 2020).

Cuando el sistema de defensa neurobiológico opta por la inmovilización o la rendición, puede surgir la disociación crónica, manifestada como desconexión emocional (alexitimia) y desconexión del cuerpo. Este mecanismo, que inicialmente protege de la sobrecarga emocional, con el tiempo limita la capacidad para sentir placer o vincularse emocionalmente. Además, es común la visión negativa persistente de uno mismo, a través de profundos sentimientos de vergüenza, culpa o inutilidad (Spinazzola et. al., 2005; van der Kolk, 2014).

1.3.2. Síntomas cognitivos.

Los síntomas cognitivos reflejan el impacto de la desregulación crónica del eje límbico-prefrontal, afectando la capacidad de la corteza prefrontal (CPF) para ejercer el control descendente (*top-down*) sobre los impulsos y las emociones límbicas. La hipervigilancia ante la amenaza consume la mayoría de los recursos cognitivos, haciendo que el cerebro filtre constantemente la información en busca de peligro (van der Kolk, 2003).

Como consecuencia, se observan alteraciones en distintos dominios cognitivos. A nivel atencional, las personas que han experimentado trauma temprano presentan dificultades para mantener la atención sostenida, alta distractibilidad y tendencia a responder de forma impulsiva a estímulos irrelevantes (van der Kolk, 2014), así como fallos en la atención selectiva y en la atención alternante (Bernate-Navarro et al., 2009). En cuanto a las funciones ejecutivas, suelen manifestar problemas para planificar, iniciar y mantener conductas orientadas a metas, así como rigidez cognitiva y dificultad para modificar estrategias ante circunstancias cambiantes o para tomar decisiones de manera reflexiva (Amores-Villalba & Mateos-Mateos, 2017).

En el ámbito de la memoria, la exposición temprana al trauma se asocia con déficits tanto en la memoria de trabajo como en el recuerdo autobiográfico incluso de eventos no traumáticos (van der Kolk, 2014), lo que compromete la construcción de una narrativa coherente del yo. Además, el procesamiento cognitivo global tiende a volverse más rígido, con menor flexibilidad, creatividad y capacidad para la resolución de problemas complejos. Estos déficits se han vinculado también con una mayor necesidad de servicios de educación especial en la infancia (Spinazzola et. al., 2014), lo que refuerza la idea de que las alteraciones derivadas del trauma temprano tienen un impacto duradero sobre el desarrollo cognitivo.

1.3.3. Síntomas conductuales.

Los síntomas conductuales son, en esencia, la manifestación externa de la desregulación afectiva y del fallo del control ejecutivo. La impulsividad, la agresividad reactiva —ya sea física o verbal— y la dificultad para modular la conducta son expresiones comunes del trauma del desarrollo. Estas alteraciones reflejan la interferencia del trauma en los circuitos de inhibición y control, y se asocian con un incremento de comportamientos de riesgo, lo que conlleva una alta comorbilidad con diagnósticos externalizantes como el TDAH (Spinazzola et al., 2005). Además, la falta de regulación conductual se ha mostrado predictiva del abuso futuro de sustancias (Rømer Thomsen et al., 2018).

El afrontamiento desadaptativo es una dimensión central del patrón conductual postraumático. Ante la activación emocional intolerable, muchos jóvenes comienzan a recurrir a estrategias destructivas, como las autolesiones no suicidas (Spinazzola et al., 2005), patrones que a menudo se consolidan en conductas de riesgo, promiscuidad o adicciones al trabajo, al ejercicio o al juego, como formas de intentar amortiguar el malestar interno o recuperar una sensación ilusoria de control (van der Kolk, 2014). Aproximadamente entre un tercio y la mitad de las personas traumatizadas desarrollan problemas con el consumo de alcohol o drogas, siendo el abuso emocional uno de los predictores más significativos de los trastornos por uso de alcohol (Downey & Crummy, 2022; Ekinci & Kandemir, 2015; O'Hare & Sherrer, 2011; Shin et al., 2015). Algunos individuos también desarrollan conductas de control rígido o perfeccionismo compulsivo como intento de recuperar una sensación de seguridad y previsibilidad perdida en la infancia (van der Kolk, 2014).

Estas conductas destructivas se relacionan estrechamente con los comportamientos autodestructivos y suicidas. El riesgo de intento de suicidio es entre dos y cinco veces mayor quienes sufrieron abuso o negligencia infantil (Dube et al., 2001; Heim et al., 2010) y el abuso sexual constituye uno de los predictores más fuertes de ideación suicida (Campbell, 2022). De este modo, las autolesiones, conductas de riesgo y adicciones aparecen como estrategias para neutralizar sensaciones corporales intolerables y gestionar el malestar emocional derivado del trauma temprano (van der Kolk, 2014).

La alteración en la regulación conductual también se manifiesta en patrones de agresión y comportamiento antisocial. Sansone et al. (2012) hallaron una relación lineal entre el número de experiencias traumáticas en la infancia y la cantidad de conductas agresivas en la adultez, siendo especialmente relevantes la exposición a la violencia y el abuso emocional. Asimismo, las personas con historia de trauma infantil presentan mayor prevalencia de Trastorno de Personalidad Antisocial (Wolff & Shi, 2012) y mayor tendencia a reproducir la violencia sufrida (DeGregorio, 2012). No obstante, otros individuos canalizan su malestar mediante retraimiento, disociación o sumisión, evidenciando el amplio espectro de respuestas conductuales ante la amenaza. Cabe destacar, sin embargo, que estas respuestas no son estáticas: muchas personas traumatizadas alternan fases de hiperactivación impulsiva con periodos de retraimiento o embotamiento conductual, reflejando la oscilación entre sistemas de defensa opuestos —lucha/huida y colapso— (Porges, 2011; van der Kolk, 2014).

Desde una perspectiva relacional, también se observan patrones conductuales desorganizados: intentos excesivos o inapropiados de búsqueda de contacto, seguidos de rechazo o agresión hacia las figuras cercanas (van der Kolk, 2014). Por otro lado, el impacto conductual del trauma no se distribuye de forma homogénea entre sexos. Perry et al. (1995) observaron que la mayoría de los niños con antecedentes de abuso y negligencia que acuden a los servicios de salud mental lo hacen por síntomas de agresión, inatención y desobediencia, siendo diagnosticados con frecuencia de TDAH, mientras que las niñas traumatizadas tienden a manifestar síntomas más internalizantes –como disociación o retraimiento– que pasan desapercibidos. Este sesgo diagnóstico refuerza la tendencia a interpretar las consecuencias del trauma en términos de trastornos del comportamiento, más que como respuestas adaptativas ante un contexto de violencia.

1.4. Más allá de los diagnósticos convencionales: hacia un enfoque transdiagnóstico del trauma.

Estas manifestaciones conductuales, cognitivas y emocionales derivadas del trauma temprano, aunque claras en la experiencia del individuo, a menudo son interpretadas de manera fragmentada en la práctica clínica. Los estudios evidencian que los niños expuestos a maltrato, violencia familiar o pérdida de figuras de apego tienden a cumplir criterios de múltiples diagnósticos —TDAH, depresión, ansiedad o trastornos de conducta— (Spinazzola et al., 2017), pero estos diagnósticos podrían estar capturando solamente fragmentos de un cuadro más amplio. Tal como señaló Herman (1992), el diagnóstico de TEPT resulta insuficiente para explicar la diversidad de síntomas derivados del trauma complejo. De hecho, la mayoría de los menores traumatizados no cumplen criterios de TEPT, sino que presentan una constelación de síntomas externalizantes e internalizantes (Humphreys et al., 2020; Klasen et al., 2013; Scheeringa & Zeanah, 2008) que el sistema actual no logra integrar.

La psicopatología tradicional se ha centrado durante décadas en sistemas categoriales como el DSM, en los que los trastornos se definen como entidades discretas, pero la elevada comorbilidad, la heterogeneidad interna de cada diagnóstico y la incapacidad de capturar la historia de desarrollo del individuo cuestionan la validez de estas categorías (Kupfer et al., 2002; Kessler et al., 2005). Como observan Hayes et al. (2015), rescatando y extendiendo las ideas sobre las que Frances y Widiger debatían décadas atrás, la proliferación de etiquetas ha terminado por construir una verdadera *"Torre de Babel"* diagnóstica: la proliferación de síndromes y subcategorías ha generado un lenguaje fragmentado y confuso que no refleja la complejidad real del sufrimiento humano. Esta sobreabundancia de categorías, lejos de facilitar la comprensión, enmascara patrones transversales que podrían ser clave para entender la relación entre experiencias tempranas adversas y síntomas psicopatológicos en la adultez.

La exposición a trauma infantil ofrece un ejemplo paradigmático de esta limitación: los mismos eventos adversos pueden conducir a una amplia gama de manifestaciones en la vida adulta, desde depresión y ansiedad hasta conductas impulsivas, dificultades atencionales o síntomas de TEPT (McLaughlin et al., 2020). La clasificación categorial tradicional dispersa estos síntomas en distintos diagnósticos, lo que dificulta identificar los mecanismos comunes subyacentes y la magnitud de su impacto transdiagnóstico.

El enfoque transdiagnóstico, centrado en síntomas y procesos psicológicos subyacentes, permite superar estas limitaciones. En lugar de estudiar trastornos aislados, se analiza cómo distintos tipos de trauma se correlacionan con patrones de síntomas en múltiples dominios: afectivo, cognitivo y conductual. Esto posibilita identificar constelaciones de síntomas que comparten raíces comunes, revelando relaciones que los sistemas categoriales fragmentados no pueden captar. Por ejemplo, la evidencia sugiere que la exposición temprana a abuso, negligencia o pérdida de figuras de apego se asocia simultáneamente con depresión, ansiedad, inatención y conductas impulsivas en la adultez, apoyando la noción de procesos transdiagnósticos (Kotov et al., 2017; McLaughlin et al., 2020).

Desde esta perspectiva, la aplicación de análisis multivariantes se propone como una vía exploratoria para mapear las correlaciones y visualizar la interconexión entre síntomas derivados del trauma temprano y manifestaciones psicopatológicas posteriores. Lejos de ser meras categorías, estos síntomas conforman constelaciones interconectadas que atraviesan los límites de los diagnósticos tradicionales. Analizarlos de manera transdiagnóstica podría permitir el hallazgo de patrones ocultos, identificar procesos psicológicos comunes y cuantificar sus interrelaciones mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad como el Biplot (Gabriel, 1971).

Este enfoque justifica un análisis basado en procesos y síntomas más que en diagnósticos rígidos, proporcionando evidencia empírica de que los “trastornos” muchas veces representan construcciones artificiales frente a patrones reales de sufrimiento humano. El uso de este tipo de técnicas no pretende sustituir la utilidad clínica del diagnóstico, sino ofrecer una ventana hacia una psicopatología adulta que no sea un mosaico de trastornos aislados, sino un entramado de respuestas adaptativas, disfuncionales y profundamente relacionadas entre sí. Solo así podemos pasar de la fragmentación de la “Torre de Babel” diagnóstica a una comprensión integral y basada en evidencia del impacto del trauma.

2. Justificación

El presente trabajo se fundamenta en la necesidad de comprender la psicopatología adulta más allá de los límites de los diagnósticos categoriales tradicionales. La evidencia sugiere que la exposición a experiencias adversas durante la infancia, como maltrato, negligencia o pérdida de figuras de apego, genera patrones de síntomas interconectados que atraviesan múltiples dominios: neurofisiológico, afectivo, cognitivo y conductual. Los enfoques convencionales, centrados en la clasificación de trastornos aislados, fragmentan estas manifestaciones y dificultan la identificación de procesos comunes subyacentes.

Adoptar un enfoque transdiagnóstico permite analizar los síntomas y procesos psicológicos de manera integral, revelando relaciones ocultas y patrones de co-ocurrencia entre síntomas de trauma temprano y manifestaciones psicopatológicas en la adultez. Este marco teórico respalda la utilización de técnicas estadísticas multivariantes, como el Biplot, para mapear correlaciones y visualizar la interconexión entre síntomas, demostrando que los trastornos a menudo representan construcciones artificiales frente a patrones reales de sufrimiento humano. De esta forma, el presente estudio busca generar un conocimiento más coherente y empíricamente fundamentado sobre la influencia del trauma infantil en la psicopatología adulta, contribuyendo a un abordaje clínico más preciso y centrado en los procesos o síntomas subyacentes.

3. Objetivos

3.1. Objetivo principal

Analizar la relación entre el trauma infantil y la psicopatología adulta desde un enfoque transdiagnóstico, identificando patrones de síntomas interconectados y procesos psicológicos subyacentes.

3.2. Objetivos secundarios

1. Identificar agrupaciones de síntomas que atraviesan los diagnósticos tradicionales en adultos con antecedentes de trauma infantil.

2. Examinar la correlación entre distintos tipos de trauma temprano (abuso, negligencia, pérdida de figuras de apego y manifestaciones afectivas, cognitivas y conductuales en la adultez.

3. Aplicar análisis multivariantes para visualizar la interconexión entre síntomas y determinar los procesos psicológicos comunes subyacentes.

4. Evaluar la pertinencia de un enfoque transdiagnóstico frente al modelo categorial tradicional para comprender la psicopatología derivada de experiencias adversas tempranas.

4. Hipótesis

1. Los adultos con antecedentes de trauma infantil presentan agrupaciones de síntomas que se solapan entre distintos diagnósticos tradicionales, evidenciando procesos transdiagnósticos.

2. La severidad y el tipo de trauma temprano se correlacionan de manera significativa con la intensidad y diversidad de síntomas afectivos, cognitivos y conductuales en la adultez.

3. El análisis multivariante permitirá identificar patrones de co-ocurrencia de síntomas que no se capturan mediante los sistemas diagnósticos categoriales convencionales.

4. Un enfoque transdiagnóstico proporciona una comprensión más integral y precisa de la psicopatología adulta derivada del trauma infantil que los modelos diagnósticos tradicionales.

5. Marco metodológico

5.1. Diseño

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se llevó a cabo un estudio de diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Al tratarse de variables que no pueden ser manipuladas deliberadamente – como es el caso de las experiencias traumáticas en la infancia – la investigación responde a un esquema *ex post facto*, analizándose los fenómenos en su contexto natural sin intervención directa por parte del investigador. Asimismo, el enfoque multivariante adoptado permite ir más allá del análisis de las relaciones lineales simples entre variables para explorar la estructura latente de los datos, facilitando así la identificación y confirmación de perfiles clínicos desde una perspectiva transdiagnóstica.

5.2. Participantes

La muestra inicial estuvo compuesta por 92 participantes. Con el fin de permitir la máxima heterogeneidad posible y asegurar la validez ecológica de los datos, se estableció un criterio de inclusión amplio con respecto a la edad (rango de 18 a 70 años). Posteriormente, se llevó a cabo un filtrado manual de la base de datos para descartar aquellos casos que presentaban patrones de respuesta incompletos. Tras un breve proceso de depuración, la muestra final válida quedó constituida por un total de $N = 90$ adultos.

En cuanto a la estrategia de reclutamiento, se empleó un muestreo no probabilístico de conveniencia y de tipo *bola de nieve*, seleccionando inicialmente a participantes accesibles y solicitando su colaboración para extender el alcance del estudio a nuevos sujetos potenciales.

5.3. Instrumentos

La recogida de información se llevó a cabo a través de una batería de preguntas online compuesta por los siguientes instrumentos:

- *Cuestionario Sociodemográfico y Contextual:* Elaborado ad-hoc para el presente estudio. Recogió variables sociodemográficas básicas (edad, género, nivel de estudios, situación laboral y situación económica) y variables contextuales relevantes al tema de análisis, tales como el nivel de apoyo percibido, la responsabilidad en tareas de cuidado y la presencia de eventos estresantes recientes.

- *Cuestionario de Trauma Infantil (CTQ-SF)*: Para medir las experiencias adversas en la infancia se utilizó la versión española, validada por Hernández et al. (2012). Esta adaptación de la escala original breve de Bernstein et al. (2003) consta de 28 ítems y permite evaluar, de forma retrospectiva, cinco dimensiones del trauma: Abuso emocional, Abuso físico, Abuso sexual, Negligencia emocional y Negligencia física. En el presente estudio, el instrumento mostró una consistencia interna global de $\alpha = 0.88$.
- *Cuestionario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI):* Para medir la sintomatología de ansiedad, se eligió el STAI (Spielberger et al. 1970), siguiendo los criterios de la adaptación española revisada por Guillén-Riquelme y Buela-Casal (2011). Este instrumento consta de 40 ítems distribuidos en dos subescalas de 20 elementos cada una. Su elección responde a una razón clínica fundamental: distinguir si la ansiedad es solo una reacción temporal del momento (Estado) o si se ha consolidado como una característica fija de la personalidad (Rasgo). Esta distinción resultó interesante en el estudio, ya que nos permite comprobar si el trauma infantil ha llegado a modificar la forma de ser del individuo o solo le provoca malestar puntual. Además, se trata de uno de los instrumentos más avalados en la literatura científica en cuanto a la medición de la ansiedad, presentando altos índices de fiabilidad. En nuestro estudio, se obtuvo un valor de consistencia interna de $\alpha = 0.95$.
- *Inventario de Depresión Rasgo – Estado (IDERE):* Se utilizó la versión validada por Martín et al. (2003). La elección de este instrumento se fundamenta en los mismos principios clínicos que justificaron el uso del STAI: la necesidad de diferenciar entre la afectación anímica circunstancial (Estado) y la disposición depresiva recurrente (Rasgo). Cabe señalar que, si bien el IDERE fue desarrollado originalmente para población cubana, su uso está ampliamente consolidado en España, contando con estudios de validación que respaldan su fiabilidad en esta población (Martín et al., 2012). Aunque inicialmente se valoró la inclusión de herramientas más breves como el IDER (Spielberger et al., 2008), se optó finalmente por el IDERE para abordar de manera más específica el solapamiento semántico y conceptual existente entre los constructos de ansiedad y depresión. Tras una revisión del contenido, se consideró que los ítems del IDERE parecen presentar una carga conceptual más distintiva, lo

que sugiere una menor redundancia con la sintomatología ansiosa y podría facilitar una discriminación más precisa entre ambos cuadros clínicos. En el presente estudio, la consistencia interna obtenida fue de $\alpha = 0.92$.

5.4. Procedimiento

El protocolo de evaluación se digitalizó e implementó a través de la plataforma *Google Forms*. La recogida de datos comenzó en el entorno académico y personal del investigador, solicitando posteriormente a los participantes la difusión del enlace a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ampliar el alcance de la muestra.

Previo al acceso a los cuestionarios, los participantes debieron leer y aceptar un consentimiento informado donde se detallaba el propósito de la investigación: analizar la relación entre experiencias adversas en la infancia y la sintomatología emocional en la adultez. En dicho documento se garantizó el anonimato de las respuestas y el tratamiento confidencial de los datos, en estricto cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, se informó explícitamente sobre el carácter voluntario de la participación y el derecho a interrumpir el cuestionario en cualquier momento sin consecuencias, facilitando un correo de contacto para la resolución de dudas o el ejercicio de derechos sobre los datos. No se ofreció ningún tipo de incentivo económico o académico por la participación.

5.5. Análisis de datos

El procesamiento y análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el entorno de programación R, junto con la interfaz RStudio. El plan de análisis se diseñó en tres fases para dar respuesta a los objetivos del estudio.

Cabe puntualizar que, para este análisis, no se emplearon los ítems de forma individual, sino que se utilizaron las puntuaciones de las subescalas de cada cuestionario, calculadas siguiendo las directrices de sus respectivos manuales clínicos. De esta forma, la matriz de análisis estuvo compuesta por las cinco dimensiones del trauma – Abuso Emocional, Físico y Sexual, y Negligencia Emocional y Física – y las puntuaciones de Ansiedad y Depresión, tanto en sus escalas de Estado como de Rasgo. A mayores, se incorporó al modelo la variable contextual

de *Eventos estresantes*, calculada como el recuento acumulado de sucesos vitales adversos experimentados por el participante en los últimos meses.

En una primera fase, se procedió a la depuración de la matriz de datos y la caracterización de la muestra. Por un lado, se calcularon los estadísticos descriptivos – frecuencias para variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas – prestando especial atención a la distribución y los posibles efectos suelo en las dimensiones de trauma. Simultáneamente, se evaluaron las propiedades psicométricas de las escalas mediante el coeficiente *Alpha de Cronbach,* para verificar la consistencia interna de las escalas y asegurar la fiabilidad de las medidas antes de proceder a análisis más complejos.

En una segunda fase, orientada a examinar la estructura latente de los datos, se ejecutó un Análisis de Componentes Principales (PCA). Este enfoque multivariante se eligió para ir más allá del análisis de correlaciones bivariadas simples y poder visualizar la covariación conjunta entre todas las variables del presente estudio, es decir, entre todas las subescalas del cuestionario de trauma y de sintomatología ansioso-depresiva adulta. Tras una previa comprobación de los supuestos de adecuación muestral (mediante el índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett), se emplearon técnicas de representación gráfica Biplot. Esto permitió observar la dirección vectorial de las variables y testar visualmente la hipótesis transdiagnóstica planteada.

Por último, en una tercera fase, se aplicó un análisis de clústeres no jerárquico (K-Means) para la identificación de perfiles clínicos diferenciados. La elección del número óptimo de grupos (k) se realizó mediante el método de la silueta, buscando la solución que ofreciera la mayor cohesión interna y separación entre grupos. Una vez definidos los clústeres, se procedió a su caracterización comparativa mediante pruebas *t de Student* para las variables cuantitativas (clínicas) y a pruebas de *Chi-cuadrado* para las variables categóricas (sociodemográficas), considerando estadísticamente significativos aquellos valores con $p < .05$.

6. Resultados

6.1. Caracterización sociodemográfica de la muestra.

La muestra final se compuso por un total de 90 participantes, con edades comprendidas entre los 19 y los 67 años. La media de edad se situó en 28.50 años $(M = 28.5; DT = 8.88)$, lo que

indica que la mayor parte de la muestra se concentra en la etapa de la adultez joven. La distribución por sexos fue muy equilibrada, con un 51.1% de hombres $(n = 46)$ y un 48.9% de mujeres $(n = 44)$.

En cuanto al perfil socioeconómico, predomina un nivel de educación medio-alto: el 90% de los participantes cuenta con estudios medios o universitarios, mientras que solo un 10% tiene la educación básica. Esta cualificación se puede ver reflejada en la situación laboral, donde la mayoría (60%) se encuentra en activo, ya sea por cuenta ajena o propia, mientras que un 26.7% corresponde a estudiantes. En consonancia con estos datos, la autopercepción económica se concentra en su mayoría en niveles intermedios: cerca del 80% de los sujetos describe su situación como "ajustada" o "suficiente", siendo minoritarios los casos tanto de precariedad como de holgura económica.

A nivel contextual y residencial, más de la mitad de la muestra (54.4%) reside en entornos no metropolitanos (zonas rurales o localidades pequeñas). Destaca también la baja carga de responsabilidades de cuidado, dado que un 68.9% de los sujetos no reporta personas dependientes a su cargo, un dato también coherente con el promedio de edad de la muestra. Con respecto al nivel de apoyo percibido por parte del entorno, el perfil resulta positivo, ya que más del 76% de los participantes percibe contar con un nivel de apoyo moderado o alto. El desglose detallado de todas las categorías sociodemográficas y contextuales se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. ***Características sociodemográficas y contextuales de la muestra***

Características de la muestra	n	%
Género		
Mujer	44	48.9
Hombre	46	51.1
Nivel de Estudios		
Bajo	9	10.0
Medio	39	43.3
Alto	42	46.7
Situación Laboral		
Desempleado(a)	11	12.2

Características de la muestra	n	%
Estudiante	24	26.7
Trabajo por cuenta ajena	43	47.8
Trabajo por cuenta propia / autónomo(a)	11	12.2
Jubilado(a)	1	1.1
Tamaño de la empresa		
1-9	19	21.1
10-49	11	12.2
50-249	7	7.8
250+	17	18.9
No aplica	36	40.0
Jornada Laboral		
Regular	36	40.0
Irregular	21	23.3
No aplica	33	36.7
Situación Económica		
Muy ajustada	10	11.1
Ajustada	34	37.8
Suficiente	37	41.1
Cómoda	9	10.0
Lugar de Residencia		
Zona rural	12	13.3
Localidad pequeña / semirrural	37	41.1
Ciudad mediana	22	24.4
Gran ciudad / área metropolitana	19	21.1
Responsabilidad en tareas de cuidado		
Sin responsabilidad	62	68.9
Baja	16	17.8
Alta	12	13.3
Nivel de apoyo percibido		
Bajo	21	23.3
Moderado	34	37.8
Alto	35	38.9

Nota. n = número de participantes; % = porcentaje válido; La edad ($M = 28.5; DT = 8.88$) se describe en el texto principal.

6.2. Propiedades psicométricas y estadísticos descriptivos de las variables clínicas.

Antes de adentrarnos en la estructura latente de los datos y la conformación de los perfiles clínicos, resulta necesario comprobar la calidad métrica de las herramientas utilizadas en el estudio. Como se indicó previamente en el apartado de los instrumentos, los índices de consistencia interna mostraron valores de 0.88 para el CTQ, 0.95 para el STAI y 0.92 para el IDERE.

En términos puramente estadísticos, un coeficiente de 0.95 podría sugerir cierta redundancia en los datos. Sin embargo, en instrumentos de corte clínico como el STAI o el IDERE estos resultados son esperables y coherentes. Esta elevada homogeneidad en las escalas responde a la naturaleza de los constructos evaluados, donde los síntomas de ansiedad y depresión suelen manifestarse de forma conjunta y solapada. A mayores, existe cierto solapamiento tanto semántico como conceptual en los ítems de ambos tests, e incluso algunos llegan a repetirse en las escalas STAI e IDERE.

Lejos de ser un inconveniente, estos niveles de fiabilidad confirman que las escalas funcionan con alta precisión en nuestra muestra. Bajo esta premisa de estabilidad métrica, podemos afirmar que los datos ofrecen un buen punto de partida para explorar la configuración de los perfiles clínicos, sin riesgo de que los resultados se vean sesgados por una falta de precisión en la medida.

Una vez confirmada la fiabilidad de los instrumentos, se procedió al análisis descriptivo de las variables clínicas, cuyos resultados desglosados se presentan en la Tabla 2. Con respecto al trauma infantil, la puntuación media global se situó en 42.12 (*DT* = 12.38). Si bien este valor sugiere una presencia moderada de experiencias adversas, destaca el predominio del abuso y la negligencia emocional frente a las formas físicas y sexuales, que mostraron puntuaciones medias notablemente más bajas.

Por su parte, la sintomatología afectiva presentó niveles consistentes en toda la muestra. Tanto la ansiedad como la depresión mostraron puntuaciones medias que oscilaron entre los 45 y 47 puntos en sus escalas de estado y rasgo, reflejando un nivel de malestar psicológico moderado. Finalmente, en relación con los eventos estresantes vitales, los participantes

reportaron una media de 2.11 sucesos (*DT* = 1.89), con un rango que abarcó desde participantes que no habían sufrido ningún evento hasta la suma de 6 situaciones estresantes.

Tabla 2. ***Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas del estudio***

Variable	n	*M*	*DT*	Mín	Máx
Edad	90	28.50	8.88	19	67
Eventos Estresantes (Nº)	90	2.11	1.89	0	6
Trauma Infantil (CTQ Total)	90	42.12	12.38	25	76
Abuso Emocional	90	9.99	4.55	5	22
Abuso Físico	90	6.31	2.77	5	18
Abuso Sexual	90	7.01	4.02	5	21
Negligencia Emocional	90	11.40	4.18	5	20
Negligencia Física	90	7.41	2.21	5	13
Ansiedad (STAI)					
Estado	90	45.90	11.87	26	79
Rasgo	90	47.30	11.15	21	73
Depresión (IDERE)					
Estado	90	46.01	8.33	26	69
Rasgo	90	45.48	11.43	22	70

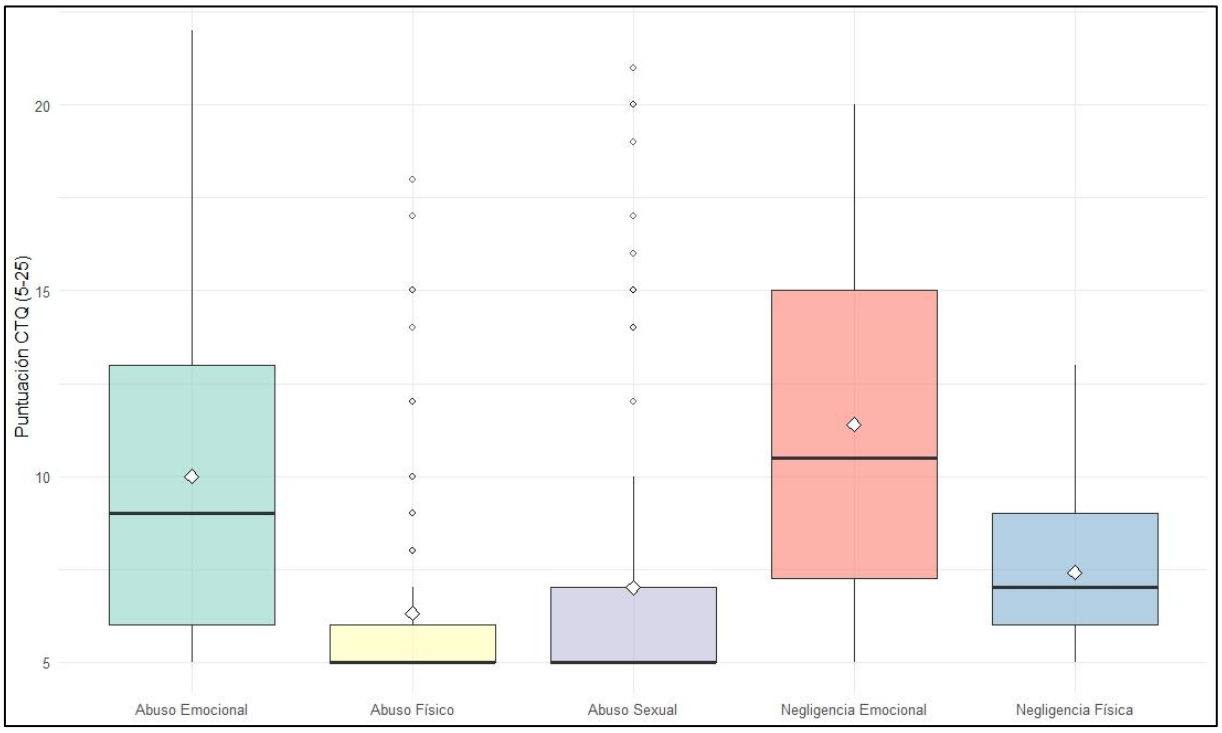
Nota. n = número de participantes; *M* = media; *DT* = desviación típica. CTQ = *Childhood Trauma Questionnaire;* STAI = *State-Trait Anxiety Inventory;* IDERE = *Inventario de Depresión Estado-Rasgo.*

6.3. Análisis de la estructura latente: distribución y contribución de las variables

Como se observó en el análisis descriptivo previo (Tabla 2), las puntuaciones medias de las distintas formas de maltrato no fueron homogéneas, lo que sugiere una baja prevalencia de las vertientes físicas y sexuales. Dado que la alta variabilidad de las subescalas es un requisito

indispensable para que los modelos de clasificación (como el análisis de clústeres) funcionen correctamente, se procedió a una exploración visual de la distribución de las subescalas del CTQ mediante diagramas de caja (*boxplots*). El objetivo fue comprobar si todas las dimensiones aportaban suficiente varianza o si, por el contrario, alguna podría estar aportando ruido al modelo. La distribución visual de estas puntuaciones se muestra en la Figura 1.

Figura 1. ***Distribución de las puntuaciones en las subescalas del CTQ-SF***



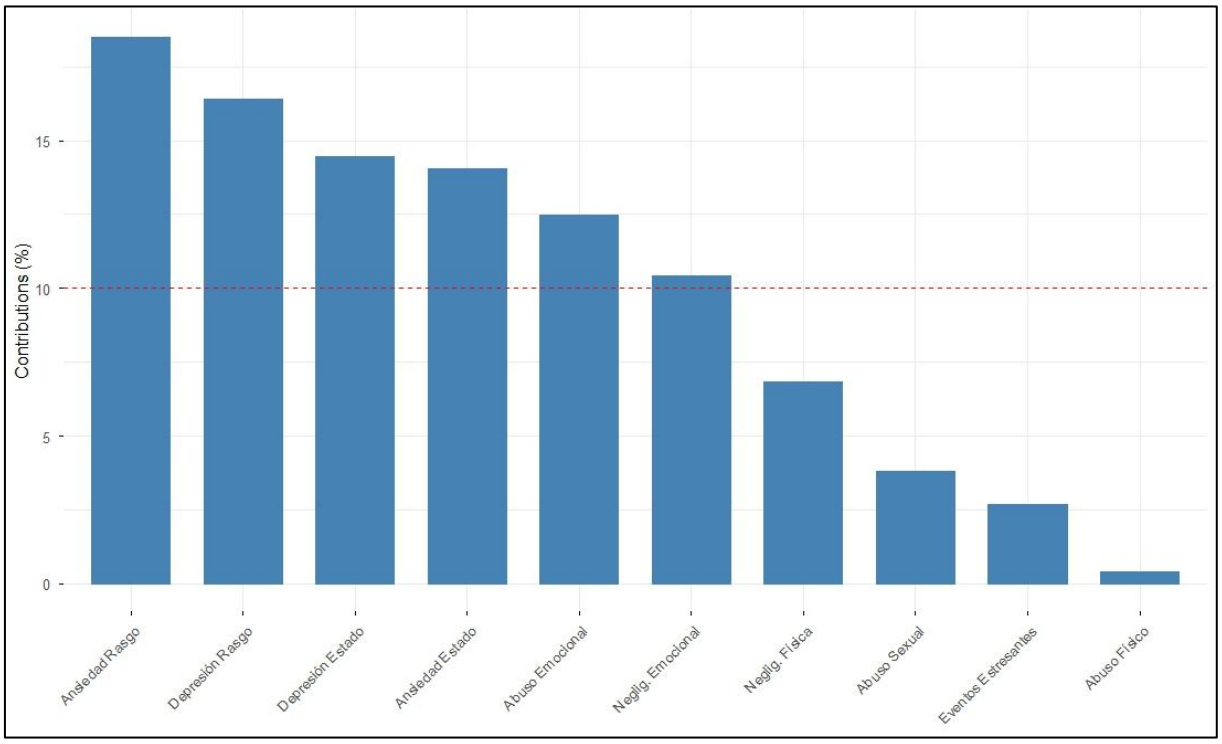
Como se puede observar, la distribución de las experiencias traumáticas no es uniforme entre las distintas dimensiones. Se aprecia una clara diferencia: por un lado, las escalas de abuso emocional y negligencia emocional presentan una alta variabilidad, con rangos intercuartílicos amplios que indican una gran diversidad de experiencias en la muestra. La negligencia física se encuentra en una posición intermedia, mostrando una dispersión moderada.

Por el contrario, las subescalas de abuso físico y abuso sexual muestran un comportamiento opuesto, caracterizado por un marcado "efecto suelo", es decir, la concentración de las respuestas en los valores mínimos. Este fenómeno es esperable en población general, donde este tipo de eventos extremos son menos frecuentes. Es relevante destacar también la presencia de numerosos valores atípicos (*outliers)* en la parte superior de estos gráficos. La existencia de casos extremos sugiere que, aunque sean infrecuentes, existen sujetos en la

muestra con niveles severos de trauma físico y sexual, lo que podría aportar información relevante para la posterior diferenciación de perfiles clínicos a pesar de la baja varianza general.

Para determinar el peso real de estas variables en la estructura latente de los datos y confirmar si el efecto suelo anula o no su utilidad, se analizó la contribución relativa de cada subescala a la formación de las componentes principales:

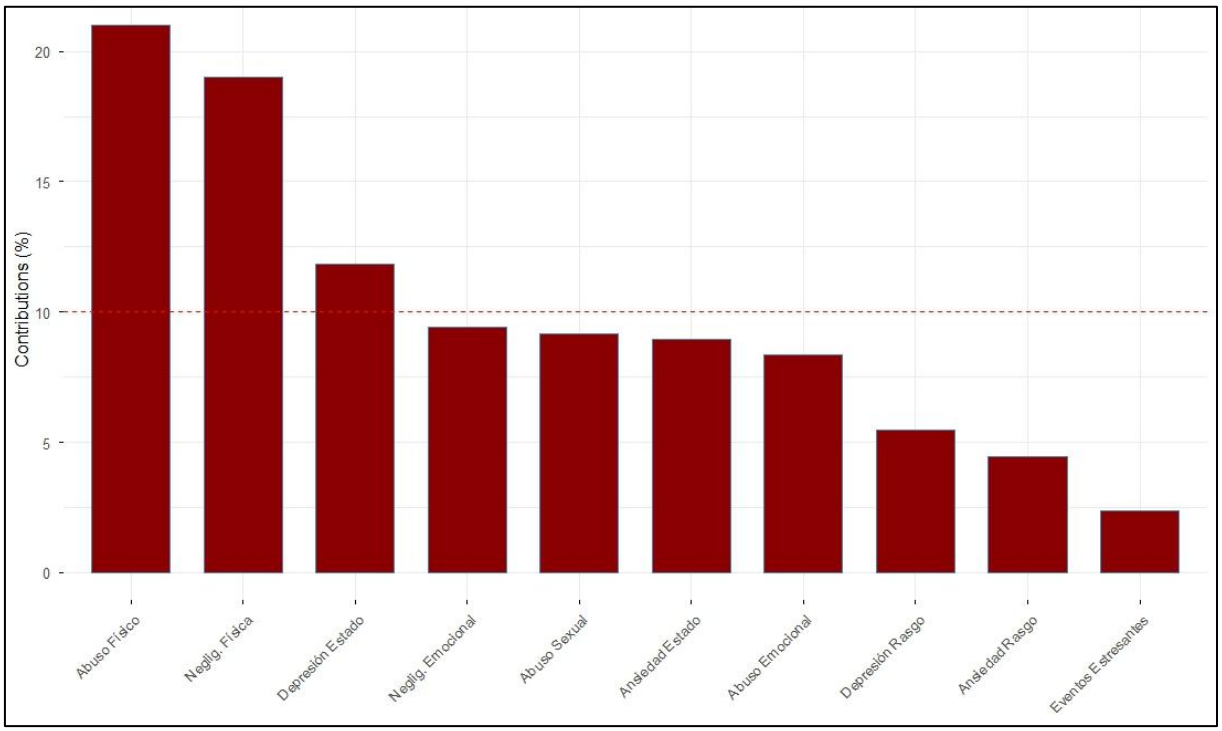
Figura 2. ***Contribución de cada subescala a la Componente Principal 1.***



La Figura 2 muestra la contribución de las variables (subescalas) a la primera Componente Principal (PC1), que explica la mayor parte de la varianza del modelo. Como se anticipaba, las variables que superan claramente el umbral de contribución media (línea discontinua roja) son las vinculadas a la sintomatología (ansiedad y depresión). De forma más atenuada, también contribuyen las dimensiones vinculadas al trauma de tipo emocional (abuso y negligencia). Por el contrario, las variables con menor varianza – como el abuso físico y sexual – quedan relegadas a las últimas posiciones en este primer eje.

Sin embargo, el análisis de la segunda Componente Principal (PC2) revela un matiz importante (véase Figura 3).

Figura 3. ***Contribución de cada subescala a la Componente Principal 2.***



Como se puede observar en la Figura 3, el perfil de contribuciones cambia con respecto a la primera componente. En este segundo eje, variables que anteriormente habían quedado relegadas debido a su menor varianza global – como el abuso físico o la negligencia física – cobran ahora un protagonismo central, superando con creces el umbral de contribución media.

Este hallazgo es importante desde el punto de vista metodológico y clínico: confirma que el efecto suelo observado en los diagramas de caja no implica una ausencia de información. Por el contrario, estas variables retienen una varianza específica e independiente a la del trauma de tipo emocional. Dicho de otro modo, el modelo matemático identifica que estas formas de maltrato no son simplemente una versión menos frecuente del abuso emocional, sino que representan un eje independiente, esencial para la identificación de los grupos clínicos.

6.4. Verificación de supuestos y estructura dimensional (PCA)

Una vez analizada la distribución de las variables y su contribución a cada Componente Principal, se procedió a evaluar si la matriz de correlaciones era adecuada para justificar la elección de la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA). Este proceso consiste en determinar si las variables de trauma y las variables clínicas – ansiedad y depresión – comparten una estructura subyacente común. En concreto, se comprueba si las escalas

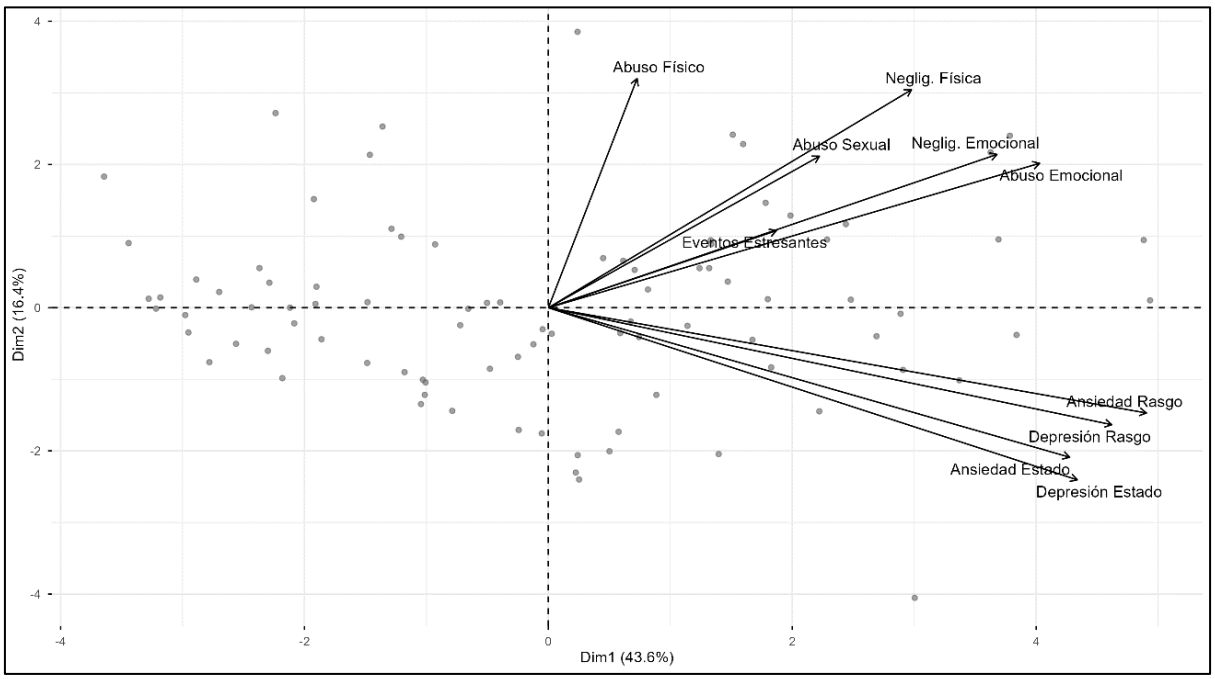
presentan correlaciones lo suficientemente altas entre sí como para justificar una reducción de la dimensionalidad.

En primer lugar, se evaluaron el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados mostraron un valor de $KMO = 0.80$, lo que indica una buena adecuación de los datos para ser factorizados. Por otro lado, la prueba de Bartlett resultó estadísticamente significativa ($\chi^2; p < 0.05$), permitiendo rechazar la hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, lo que significa que las subescalas no son independientes entre sí, y que presentan una intercorrelación suficiente para ser analizadas de forma conjunta. Ambos indicadores confirmaron que la estructura de los datos era apta para la aplicación del PCA.

Tras verificar dichos supuestos, se ejecutó el PCA, el cual reveló que las dos primeras componentes principales explicaban conjuntamente el 59.97% de la varianza total. Cabe destacar que la primera componente (PC1) explica por sí sola el 43.61% de la varianza en los datos, mientras que la segunda componente (PC2) explica un 16.36%. Este alto porcentaje de varianza explicada sugiere que la PC1 actúa como el eje principal para diferenciar a los sujetos de la muestra. Por otro lado, la PC2 probablemente esté capturando la especificidad o los matices estructurales que escapan a esa primera clasificación general.

Para visualizar la representación gráfica de esta estructura y observar cómo se distribuyen conjuntamente todos los sujetos y todas las escalas en el espacio bidimensional, se presenta el Biplot en la Figura 4.

Figura 4. ***Biplot: Representación simultánea de las variables (vectores) y los sujetos (puntuaciones individuales) sobre las dos primeras componentes principales.***



Para facilitar la interpretación de este análisis, conviene aclarar que el Biplot permite visualizar en un solo plano dos tipos de información: la posición de los sujetos (puntos) y la fuerza de las variables (flechas). En este sentido, la cercanía entre los puntos indica que esos participantes tienen perfiles clínicos similares, mientras que la dirección de las flechas nos indica qué variables están desplazando a los sujetos hacia una zona u otra del gráfico. Cuanto más larga es una flecha y más se aproxima a los ejes de coordenadas, mayor es su peso a la hora de definir esa componente.

Si observamos la Figura 4, resulta evidente que la primera componente es la que establece la verdadera diferencia entre los individuos de la muestra. Se aprecia que las flechas correspondientes a la ansiedad, la depresión y el trauma emocional (tanto abuso como negligencia) se proyectan con gran longitud hacia el extremo derecho del eje horizontal.

En la práctica, esto significa que la PC1 funciona como un factor general de gravedad transdiagnóstica: los sujetos situados a la derecha son aquellos que presentan puntuaciones altas en todas las variables de forma simultánea, diferenciándose claramente de los perfiles situados a la izquierda, que presentan una sintomatología más baja. Por el contrario, las variables de trauma físico y sexual muestran vectores más cortos y con menor proyección horizontal. Esto indica que su *fuerza* para diferenciar a los individuos es más débil en este

primer eje de gravedad general, lo cual es coherente con el efecto suelo observado en su medición. No obstante, tal y como se evidenció en el análisis de contribuciones (Figura 3), esto no implica que sean irrelevantes.

Si desplazamos la atención al eje vertical (PC2), la configuración estructural cambia radicalmente. En esta dimensión, se observa cómo los vectores correspondientes al trauma físico y al abuso sexual se distancian del bloque de sintomatología ansioso-depresiva. A diferencia de lo que ocurría en el eje horizontal – donde todas las variables apuntaban en una misma dirección de *gravedad* –, aquí estas formas específicas de maltrato muestran una trayectoria propia. Esto sugiere que la varianza de este segundo eje no se debe a la gravedad de los síntomas, sino a la configuración cualitativa del cuadro: se contraponen el predominio de historia de trauma frente a la intensidad del estado emocional actual.

Por tanto, los resultados indican que la muestra no solo difiere en la *severidad global*, sino también en la *tipología predominante*. Este hallazgo justifica la pertinencia de avanzar hacia la identificación de perfiles clínicos mediante un análisis de clústeres, ya que confirma la existencia de una heterogeneidad cualitativa en los datos que un simple análisis descriptivo o correlacional no puede capturar.

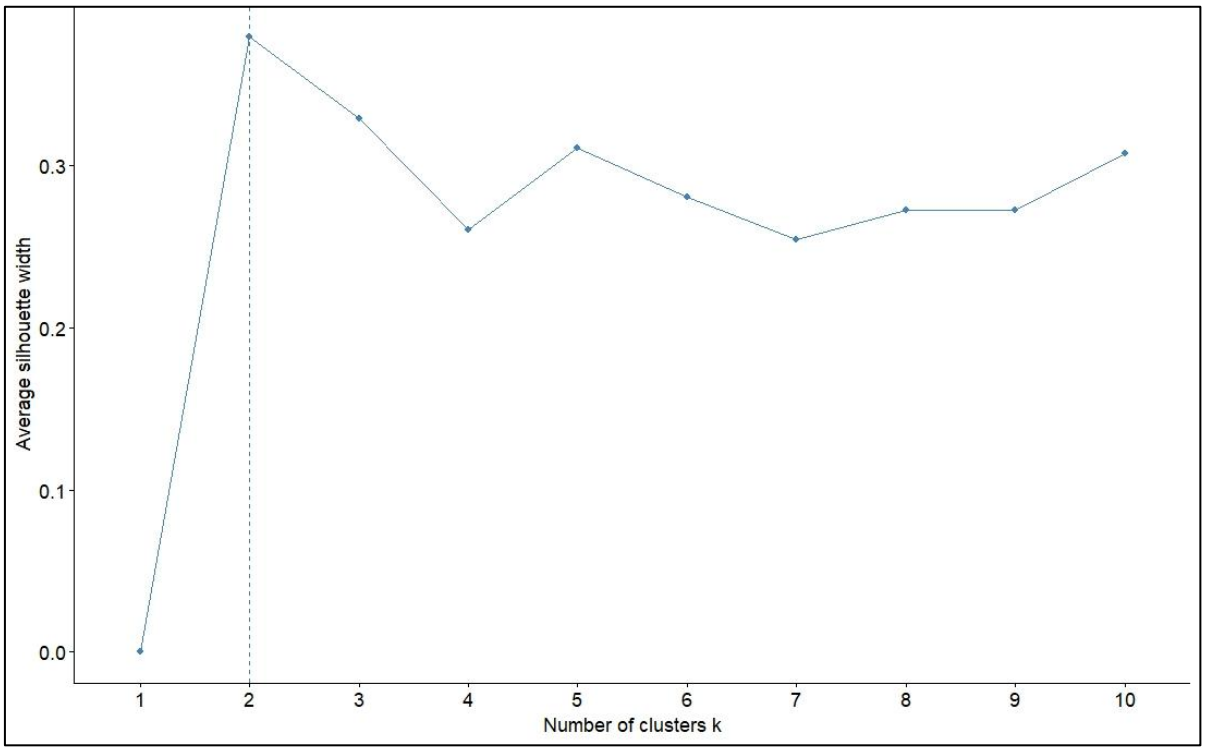
6.5. Evaluación del agrupamiento y determinación del número de perfiles

Antes de proceder a clasificar a los sujetos, fue fundamental comprobar si los datos realmente presentaban una estructura definible o si, por el contrario, se distribuían al azar. Para evaluar esta tendencia al agrupamiento de los datos y descartar que la muestra se distribuyese aleatoriamente en el espacio, se calculó el estadístico de Hopkins.

El análisis arrojó un valor de $H = 0.66$. Dado que este indicador supera el umbral de 0.5 – el cual indicaría aleatoriedad pura – los resultados sugieren la existencia de una estructura latente organizada. Si bien el valor denota una tendencia moderada al agrupamiento, se consideró suficiente para justificar la búsqueda de perfiles diferenciados, asumiendo la naturaleza continua de las variables psicopatológicas analizadas.

Una vez confirmada la pertinencia del análisis, el siguiente paso fue determinar cuál era el número óptimo de grupos (k). Para ello, se utilizó el *método de la silueta*, cuyos resultados se muestran en la Figura 5.

Figura 5. ***Representación gráfica del método de la silueta.***

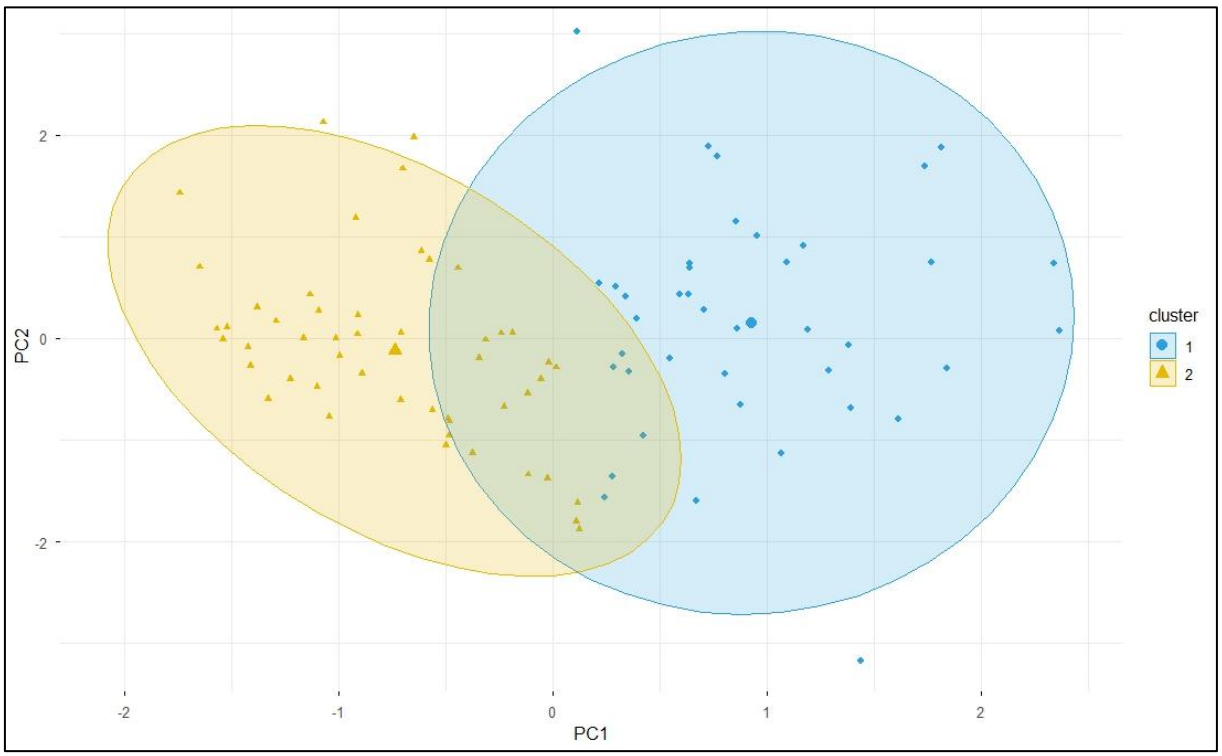


Tal y como se observa en la gráfica, la solución de clústeres $(k = 2)$ resultó ser la opción más sólida, alcanzando el índice de silueta más elevado, con un valor aproximado de 0.37. A pesar de que este valor refleja una cohesión moderada – lo cual es esperable al trabajar con constructos psicopatológicos que se distribuyen en un continuo y no en categorías rígidas – señala que el punto de corte óptimo es de dos grupos. Se aprecia cómo, al intentar forzar una solución de tres o más grupos, la calidad del agrupamiento desciende abruptamente, obteniendo valores por debajo de 0.30. Esto sugiere que la estructura latente de la muestra se ajusta mejor a una configuración de dos perfiles diferenciados, descartando fragmentaciones más complejas.

6.6. Configuración espacial y caracterización clínica de los perfiles latentes.

Para confirmar visualmente la separación entre ambos grupos y poder examinar cómo se distribuyen en el espacio los sujetos clasificados, se proyectó la solución de dos grupos sobre el plano factorial de la PCA (Figura 6.)

Figura 6. ***Proyección espacial de los dos clústeres sobre las dos primeras componentes principales, con elipses de confianza al 95% alrededor de los centroides.***



Nota. Véase que el clúster 1 corresponde al grupo de la derecha (en azul), mientras que el 2 corresponde al de la izquierda (en amarillo).

Como se puede apreciar, la formación de las elipses permite distinguir dos regiones claras, que se distribuyen principalmente a lo largo del eje horizontal (PC1). Este patrón es congruente con la estructura factorial hallada previamente, donde la primera componente explicaba la mayor parte de la varianza del modelo (43.61%). Dado que la PC1 actúa como un gradiente de gravedad general – integrando la carga traumática y la intensidad de los síntomas – resulta lógico que la clasificación principal de los sujetos se oriente en esa dirección.

En esta línea, esta disposición espacial sugiere que el factor determinante que separa a los grupos es de naturaleza cuantitativa: la muestra se polariza entre aquellos sujetos situados a la izquierda (menor severidad de síntomas y eventos traumáticos) y aquellos desplazados hacia la derecha (mayor severidad).

Por otro lado, la zona de solapamiento central resulta coherente con la distribución de las variables en la muestra analizada. Al tratarse de constructos medidos en un continuo, los datos no están dibujando límites abruptos, sino una transición gradual. Esta intersección representa a los participantes con perfiles intermedios, lo que matiza la clasificación obtenida:

si bien la separación entre grupos es estadísticamente robusta – dada la distancia entre sus centroides –, la realidad clínica de estos sujetos responde más a un gradiente de vulnerabilidad que a un sistema de categorías discretas.

No obstante, más allá de la configuración espacial de los datos, resultaba imprescindible dotar de significado clínico a la estructura latente. Para ello, se procedió a la caracterización de los perfiles mediante la comparación estadística entre ambos grupos. Con este análisis se persiguieron dos objetivos: por un lado, verificar si la separación observada en el gráfico se traducía en diferencias significativas en cuanto a gravedad de síntomas y carga traumática; y por otro, explorar si existían factores sociodemográficos distintivos – como la edad, el género o el nivel socioeconómico – que pudieran estar condicionando la pertinencia a uno u otro perfil.

Caracterización del perfil clínico y psicopatológico

Para llevar a cabo esta caracterización, se realizó un análisis comparativo de diferencias de medias. Específicamente, se aplicó la prueba t de Student para muestras independientes, tomando como variable de agrupación la pertenencia al clúster y como variables dependientes las puntuaciones totales en las escalas de trauma (CTQ), ansiedad (STAI) y depresión (IDERE), así como el recuento acumulado de eventos estresantes. Se asumió un nivel de significación estadística de $p < .05$ para determinar la existencia de diferencias relevantes entre ambos grupos ($n_{Clúster\ 1} = 40$; $n_{Clúster\ 2} = 50$). En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos.

Tabla 3. ***Comparación de variables clínicas y de trauma entre los perfiles clínicos.***

Variable	Clúster 1 (n = 40)	Clúster 2 (n = 50)	Sig. (p)
Trauma Infantil (CTQ)	52.08 (11.03)	34.16 (5.99)	< **.001**
Ansiedad Rasgo (STAI)	56.15 (7.92)	40.22 (7.79)	< **.001**
Depresión Rasgo (IDERE)	54.52 (7.92)	38.24 (8.20)	< **.001**
Eventos Estresantes (Nº)	2.58 (1.96)	1.74 (1.76)	**0.039**

En consonancia con la distribución espacial observada anteriormente, el análisis confirmó diferencias estadísticamente significativas y de gran magnitud $p < .001$ en todas las variables clínicas, permitiendo definir los grupos de la siguiente forma:

En primer lugar, tenemos el Clúster 1, caracterizado por una alta vulnerabilidad. Este grupo, que representa al 44.4% de la muestra, se distingue por mostrar una elevada carga de eventos adversos tempranos ($M_{CTQ} = 52.08$) y un estado actual de malestar psicológico severo ($M_{STAI} = 56.15$; $M_{IDERE} = 54.52$), que indican una afectación significativa. Asimismo, reportan una mayor acumulación de eventos estresantes recientes ($M_{EE} = 2.58$). Espacialmente, este perfil se corresponde con los sujetos situados en la región positiva de la PC1, es decir, la zona derecha del gráfico.

Por otro lado, el Clúster 2 se caracteriza por una baja vulnerabilidad. Conformado por el 55.6% de los participantes, este perfil muestra niveles bajos de trauma infantil ($M_{CTQ} = 34.16$) y una sintomatología contenida ($M_{STAI} = 40.22$; $M_{IDERE} = 38.24$). Se puede observar que, aunque estos sujetos no están exentos de eventos estresantes vitales, su impacto clínico parece significativamente menor, sugiriendo una mayor capacidad de regulación o resiliencia. Este perfil se corresponde con la región izquierda del espacio factorial.

Análisis de factores sociodemográficos

Finalmente, se exploró si la pertinencia a estos perfiles estaba condicionada por factores contextuales, con el objetivo de determinar si la vulnerabilidad detectada es un fenómeno transversal o si depende de características específicas de la muestra. Para ello, se compararon ambos grupos en función de las variables sociodemográficas registradas, utilizando la prueba *t* de Student para la edad y la prueba de Chi-cuadrado para las variables categóricas.

Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. ***Comparación sociodemográfica entre los perfiles clínicos.***

Variable	Clúster 1 (n=40)	Clúster 2 (n=50)	Sig. (p)
Edad (Media, DT)	29.95 (10.09)	27.34 (7.69)	0.181
Género			0.199
Mujer	23 (57.5%)	21 (42.0%)	
Hombre	17 (42.5%)	29 (58.0%)	
Nivel de Estudios			0.520
Bajo	5 (12.5%)	4 (8.0%)	
Medio	19 (47.5%)	20 (40.0%)	
Alto	16 (40.0%)	26 (52.0%)	
Situación Laboral			0.466
Desempleado(a)	7 (17.5%)	4 (8.0%)	
Estudiante	12 (30.0%)	12 (24.0%)	
Trabajo por cuenta ajena	16 (40.0%)	27 (54.0%)	
Trabajo por cuenta propia / autónomo(a)	5 (12.5%)	6 (12.0%)	
Jubilado(a)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	
Tamaño de la Empresa			0.057
1-9	11 (27.5%)	8 (16.0%)	
10-49	2 (5.0%)	9 (18.0%)	
50-249	3 (7.5%)	4 (8.0%)	
250+	4 (10.0%)	13 (26.0%)	
No aplica	20 (50.0%)	16 (32.0%)	
Jornada Laboral			**0.025**
Regular	10 (25.0%)	26 (52.0%)	
Irregular	13 (32.5%)	8 (16.0%)	
No aplica	17 (42.5%)	16 (32.0%)	
Situación Económica			0.114
Muy ajustada	6 (15.0%)	4 (8.0%)	
Ajustada	19 (47.5%)	15 (30.0%)	
Suficiente	11 (27.5%)	26 (52.0%)	
Cómoda	4 (10.0%)	5 (10.0%)	
Lugar de Residencia			0.595
Zona rural	4 (10.0%)	8 (16.0%)	
Localidad pequeña / semirrural	17 (42.5%)	20 (40.0%)	
Ciudad mediana	12 (30.0%)	10 (20.0%)	
Gran ciudad / área metropolitana	7 (17.5%)	12 (24.0%)	
Tareas de Cuidado			0.697
Sin responsabilidad	28 (70.0%)	34 (68.0%)	
Baja	8 (20.0%)	8 (16.0%)	
Alta	4 (10.0%)	8 (16.0%)	
Apoyo Social Percibido			**0.009**
Bajo	15 (37.5%)	6 (12.0%)	
Moderado	15 (37.5%)	19 (38.0%)	
Alto	10 (25.0%)	25 (50.0%)	

El análisis estadístico reveló un patrón de resultados mixto. Por un lado, la vulnerabilidad clínica se mostró independiente de variables estructurales básicas: no se hallaron diferencias significativas $(p > .05)$ en función de la edad, el género, el nivel de estudios, la situación laboral, el tamaño de la empresa, la situación económica, el lugar de residencia ni la responsabilidad en tareas de cuidado. Esto descarta que el perfil de gravedad esté sesgado por cuestiones generacionales o de estatus material.

Sin embargo, se detectaron diferencias estadísticamente significativas $(p < .05)$ en dos dimensiones contextuales clave: la jornada laboral y el apoyo social percibido.

En relación a la jornada laboral, la estabilidad horaria apareció asociada al perfil resiliente. El perfil adaptativo presentó una mayor prevalencia de jornadas regulares $(n = 26)$ en comparación con el perfil vulnerable $(n = 10)$. Por el contrario, la irregularidad horaria o el trabajo por turnos fueron más frecuente en el perfil de alta vulnerabilidad, con 13 sujetos frente a los 8 del grupo adaptativo.

El contraste resultó aún más marcado en el apoyo social percibido, variable que mostró la mayor capacidad discriminante. El perfil de mayor gravedad clínica se caracterizó por una percepción de aislamiento: 15 sujetos del Clúster 1 reportaron un nivel de apoyo bajo, frente a solo 6 del Clúster 2. Inversamente, la red social de contención fue significativamente más sólida en el grupo adaptativo, donde la mitad de sus integrantes $(n = 25)$ se situó en el nivel de apoyo alto, en contraste con los 10 sujetos del grupo vulnerable.

Estos hallazgos matizan la transversalidad del fenómeno: si bien el trauma no distingue por edad o nivel de ingresos, la inestabilidad en los ritmos vitales y la ausencia de una red de apoyo sólida emergen como factores contextuales distintivos del perfil de mayor riesgo psicopatológico.

7. Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la relación entre el trauma infantil y la psicopatología adulta desde un enfoque transdiagnóstico. Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis de que la sintomatología postraumática no tiende a adherirse a las taxonomías diagnósticas tradicionales, sino que parece configurar una estructura latente de vulnerabilidad generalizada que trasciende los dominios afectivos, cognitivos y conductuales.

En sintonía con la tercera hipótesis, el empleo de un análisis multivariante ha resultado fundamental para identificar patrones de co-ocurrencia entre síntomas que el modelo categorial clásico suele fragmentar, permitiendo visualizar la interconexión real de los datos. Esta estructura se manifestó en la primera componente principal, la cual mostró una convergencia significativa entre la sintomatología ansioso-depresiva y las experiencias de trauma emocional. La asociación de estas variables sugiere que, en la muestra analizada, el malestar clínico y la historia de trauma no operan como variables ortogonales, sino que constituyen un continuo de severidad: el incremento en los indicadores de abuso o negligencia emocional correlaciona intrínsecamente con una mayor desregulación afectiva actual. Esta covariación apoya empíricamente a la conceptualización del *Factor p*, propuesto por Caspi et al. (2014), indicando que la comorbilidad observada podría no ser la suma de trastornos discretos, sino la manifestación de una dimensión subyacente de psicopatología general. En este sentido, nuestros resultados se alinean con las perspectivas contemporáneas que abogan por modelos dimensionales frente a la fragmentación categorial clásica (McLaughlin et al., 2020), evidenciando que, en la práctica clínica, las fronteras entre el trauma y sus secuelas sintomáticas son difusas.

Si bien el presente diseño no incluyó medidas de neuroimagen, los correlatos conductuales observados – caracterizados por una elevada ansiedad rasgo y desregulación afectiva – son consistentes con los modelos neurobiológicos revisados en la literatura. La convergencia hallada entre trauma emocional y sintomatología afectiva podría interpretarse como la expresión fenotípica de la sensibilización del eje HPA y la hiperreactividad amigdalina descritas por Van der Kolk (2003) y Teicher y Samson (2016). Es plausible hipotetizar, entonces, que el *desgaste emocional sostenido* detectado en nuestra muestra refleja, a nivel estructural, las alteraciones en la conectividad frontolímbica que dificultan la inhibición prefrontal ante estímulos estresantes, perpetuando así el estado de alerta fisiológica que subyace al factor general de gravedad identificado.

Resulta particularmente relevante la posición central que ocupan el abuso y la negligencia emocional en este eje de gravedad, diferenciándose de las formas físicas de maltrato. Mientras que el componente emocional parece actuar como el motor principal del malestar generalizado, los tipos de trauma físico y sexual se segregaron en una dimensión independiente y cualitativamente distinta. Esta disociación es consistente con la literatura que

señala al maltrato psicológico como un predictor de resultados clínicos tan severos o más que el abuso físico, dada su capacidad para erosionar el autoconcepto y los mecanismos de autorregulación (Spinazzola et al., 2014). Por otro lado, la segregación del trauma físico en un segundo eje podría reflejar el "efecto suelo" habitual en muestras comunitarias donde, tal como advierten Stoltenborgh et al. (2011), estas formas de violencia presentan una menor prevalencia, comportándose como eventos de alta especificidad más que como un desgaste emocional sostenido.

La traducción de esta estructura latente en perfiles clínicos mediante el análisis de clústeres permitió observar un fenómeno de acumulación de riesgo. Validando la segunda hipótesis del estudio, la marcada polarización en dos grupos, uno de alta vulnerabilidad y otro adaptativo, sugiere que la patología emerge, probablemente, de una relación dosis-respuesta (Felitti et al., 1998). Es notable que el perfil de mayor gravedad no solo reportase mayores antecedentes traumáticos, sino también una carga significativamente superior de eventos estresantes recientes. Esta co-ocurrencia es coherente con el modelo de carga alostática descrito por Danese y McEwen (2012), según el cual la exposición temprana a la adversidad podría recalibrar los sistemas de respuesta al estrés, generando una sensibilización que dificulta la gestión de las demandas de la vida adulta y perpetúa un ciclo de vulnerabilidad.

Finalmente, al indagar en los factores contextuales que podrían moderar esta trayectoria, se observó que las variables socioeconómicas estructurales – como el nivel educativo o los ingresos – carecieron de capacidad discriminante entre los grupos, lo que subraya la transversalidad del impacto traumático. No obstante, dos elementos emergieron como protectores fundamentales: el apoyo social y la estabilidad de los ritmos vitales, reflejada a través de la regularidad de la jornada laboral. La solidez de la red de apoyo percibida se consolidó como el diferenciador más robusto, reforzando la noción de que el vínculo social opera como un mediador crítico en la resiliencia postraumática. La asociación hallada entre la irregularidad de la jornada laboral y la pertenencia al perfil vulnerable introduce una perspectiva interesante sobre la cronobiología del trauma. Este hallazgo resuena con la teoría de los ritmos sociales (Ehlers et al., 1988), sugiriendo que la desestructuración de los ritmos externos – o *zeitgebers* sociales – elimina los sincronizadores sociales necesarios para la regulación fisiológica, intensificando así la inestabilidad subyacente en aquellos con historia de trauma.

Desde una perspectiva aplicada a la Psicología General Sanitaria, estos hallazgos tienen implicaciones directas para la práctica terapéutica. La evidencia de que la regularidad de los ritmos y el soporte social discriminan mejor entre perfiles de gravedad que las variables sociodemográficas sugiere la necesidad de incorporar estrategias de estabilización *de abajo hacia arriba (bottom-up)*. El tratamiento del trauma complejo no debería limitarse al procesamiento cognitivo del evento, sino priorizar intervenciones que restauren los andamiajes externos – higiene del sueño, estructuración de rutinas y activación conductual social – como paso previo indispensable para reducir la carga alostática y facilitar la regulación emocional.

En conclusión, los hallazgos del presente estudio invitan a retomar la reflexión inicial sobre la naturaleza de nuestros modelos diagnósticos. Si, como advertían autores como Eysenck, Widiger o Frances, el sistema categorial ha funcionado históricamente como un *lecho de Procusto*, los resultados obtenidos mediante el análisis de componentes principales y el Biplot nos han permitido, en esta muestra, dejar de forzar la realidad clínica para que encaje en la etiqueta.

Al visualizar el "territorio" de los síntomas sin las restricciones del "mapa" tradicional, se observa que la división entre ansiedad y depresión se desvanece en favor de un *Factor* p de vulnerabilidad generalizada. Este enfoque transdiagnóstico permite clarificar la estructura del sufrimiento del individuo y ofrece una salida a la Torre de Babel diagnóstica: en lugar de una proliferación de etiquetas inconexas, los datos sugieren un lenguaje común basado en procesos de desregulación psicobiológica. Reconociendo esta continuidad y atendiendo a los andamiajes externos —como los ritmos sociales y el apoyo percibido— podremos acercarnos más a una visión que adapte el tamaño del lecho al viajero, no el tamaño del viajero al lecho.

7.1. Limitaciones

No obstante, la interpretación de estos resultados debe considerarse a la luz de ciertas limitaciones metodológicas. El diseño transversal del estudio impide establecer relaciones de causalidad directa entre los ritmos sociales y la sintomatología, no pudiendo descartarse una causalidad inversa donde sea la propia psicopatología la que desestructure las rutinas laborales.

Asimismo, deben señalarse restricciones relativas a la muestra. El tamaño obtenido ($N = 90$), aunque resulta suficiente para la detección de estructuras latentes generales, limita la potencia estadística para explorar subgrupos más específicos. A esto se añade la naturaleza no probabilística del muestreo —realizado por conveniencia y bola de nieve— lo cual podría introducir sesgos de selección y homogeneidad que restrinjan la validez ecológica de los hallazgos. Sería deseable, por tanto, replicar este modelo en muestras clínicas formalmente diagnosticadas y aleatorizadas para garantizar una mayor representatividad del espectro psicopatológico.

Finalmente, cabe mencionar una limitación instrumental en la medición de la variable depresiva. Si bien el inventario IDERE posee propiedades psicométricas adecuadas, su uso es menos frecuente en la literatura internacional comparado con herramientas estandarizadas como el BDI-II. Esta particularidad sugiere cierta cautela a la hora de contrastar directamente los niveles absolutos de sintomatología depresiva con los reportados en estudios anglosajones, aunque no invalida las correlaciones estructurales halladas.

7.2. Prospectiva

A la luz de las limitaciones expuestas, las futuras líneas de investigación deberían orientarse hacia un refinamiento metodológico que permita capturar la complejidad inherente a la psicopatología del trauma. Resulta necesario evolucionar desde los muestreos por conveniencia hacia diseños de casos y controles que contrasten perfiles clínicos formalmente diagnosticados con grupos de control no clínicos. Una aproximación de este tipo facilitaría la delimitación más precisa de los umbrales de vulnerabilidad y permitiría validar si las estructuras latentes identificadas en este estudio mantienen su estabilidad en entornos de mayor severidad sintomática.

Por otro lado, parece fundamental apostar por diseños longitudinales que permitan observar con mayor claridad la direccionalidad de las relaciones entre variables psicopatológicas. Sin un seguimiento temporal, resulta complejo determinar si la estabilidad en los ritmos sociales actúa como un factor que precede y protege al individuo, o si la organización de las rutinas es, en realidad, un resultado propio del proceso de mejoría clínica.

A mayores, la investigación futura se vería enriquecida al ampliar el espectro de variables analizadas. Resultaría de gran interés indagar en la coexistencia de otros cuadros transdiagnósticos, como el TDAH o el TEPT, cuya sintomatología se solapa frecuentemente con los dominios afectivos evaluados en este trabajo. Bajo esta perspectiva, la sustitución de instrumentos como el IDERE por herramientas de mayor sensibilidad clínica y consenso emocional podría reducir la variabilidad métrica y favorecer la comparabilidad de los hallazgos en marcos más globales. No obstante, el avance más significativo podría derivarse de la integración de técnicas de neuroimagen funcional y estructural, dada la naturaleza multidimensional del trauma.

Referencias bibliográficas

Amores-Villalba, A., & Mateos-Mateos, R. (2017). Revisión de la neuropsicología del maltrato infantil: La neurobiología y el perfil neuropsicológico de las víctimas de abusos en la infancia. *Psicología Educativa, 23*(2), 81-88. https://doi.org/10.1016/j.pse.2017.05.006

Bernate-Navarro, M., Baquero-Vargas, M. P., & Soto-Pérez, F. (2009). Diferencias en los procesos de atención y memoria en niños con y sin estrés postraumático. *Cuadernos de Neuropsicología, 3*(1), 104-127.

Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., Stokes, J., Handelsman, L., Medrano, M., Desmond, D., & Ziedonis, D. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. *Child Abuse & Neglect, 27*(2), 169–190. https://doi.org/10.1016/s0145-2134(02)00541-0

Campbell, K. A. (2022). The neurobiology of childhood trauma, from early physical pain onwards: As relevant as ever in today's fractured world. *European Journal of Psychotraumatology, 13*(2), 2131969. https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2131969

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? *Clinical Psychological Science, 2*(2), 119–137. https://doi.org/10.1177/2167702613497473

Cervera Pérez, I. M., López-Soler, C., Alcántara-López, M., Castro Sáez, M., Fernández-Fernández, V., & Martínez Pérez, A. (2020). Consecuencias del maltrato crónico intrafamiliar en la infancia: Trauma del desarrollo. *Papeles del Psicólogo, 41*(3), 209-217. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2020.2934

Danese, A., & McEwen, B. S. (2012). Adverse childhood experiences, allostasis, allostatic load, and age-related disease. *Physiology & Behavior, 106*(1), 29–39. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.08.019

da Silva, B. S., Grevet, E. H., Silva, L. C. F., Ramos, J. K. N., Rovaris, D. L., & Bau, C. H. D. (2023). An overview on neurobiology and therapeutics of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Discover Mental Health, 3*, 2. https://doi.org/10.1007/s44192-022-00030-2

DeGregorio, L. J. (2012). Intergenerational transmission of abuse: Implications for parenting interventions from a neuropsychological perspective. *Traumatology, 19*(2), 158–166. https://doi.org/10.1177/1534765612457219

Downey, C., & Crummy, A. (2022). The impact of childhood trauma on children's wellbeing and adult behavior. *European Journal of Trauma & Dissociation, 6*(1), 100237. https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100237

Dube, S. R., Anda, R. F., Felitti, V. J., Chapman, D. P., Williamson, D. F., & Giles, W. H. (2001). Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: Findings from the Adverse Childhood Experiences Study. *JAMA, 286*(24), 3089–3096. https://doi.org/10.1001/jama.286.24.3089

Ehlers, C. L., Frank, E., & Kupfer, D. J. (1988). Social zeitgebers and biological rhythms: A unified approach to understanding the etiology of depression. *Archives of General Psychiatry, 45*(10), 948–952. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1988.01800340076012

Ekinci, S., & Kandemir, H. (2015). Childhood trauma in the lives of substance-dependent patients: The relationship between depression, anxiety and self-esteem. *Nordic Journal of Psychiatry, 69*(4), 249-253. https://doi.org/10.3109/08039488.2014.972456

Eysenck, H. J. (1995). Psychopathology: Type or trait? *Behavioral and Brain Sciences, 18*(3), 555–556. https://doi.org/10.1017/S0140525X00039765

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine, 14*(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00017-8

Frances, A. (1993). Dimensional diagnosis of personality—Not whether, but when and which. *Psychological Inquiry, 4*(2), 110–111. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0402_7

Gabriel, K. R. (1971). The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. *Biometrika, 58*(3), 453-467.

Guerrero-Velázquez, A. (2024). El trauma está en la respuesta: Hacia una visión postcausal en la definición de trauma psicológico. *Revista de Humanidades de Valparaíso*, (26), 75-102. https://doi.org/10.22370/rhv2024iss26pp75-102

Guillén-Riquelme, A., & Buela-Casal, G. (2011). Actualización psicométrica y funcionamiento diferencial de los ítems en el State Trait Anxiety Inventory (STAI). *Psicothema, 23*(3), 510-515.

Gunn, B. G., Cunningham, L., Cooper, M. A., Corteen, N. L., Seifi, M., Swinny, J. D., Lambert, J. J., & Belelli, D. (2013). Dysfunctional astrocytic and synaptic regulation of hypothalamic glutamatergic transmission in a mouse model of early-life adversity: Relevance to neurosteroids and programming of the stress response. *The Journal of Neuroscience, 33*(50), 19534–19554. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1337-13.2013

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2015). *Terapia de aceptación y compromiso: Proceso y práctica del cambio consciente (Mindfulness)*. Desclée De Brouwer.

Heim, C., Shugart, M., Craighead, W. E., & Nemeroff, C. B. (2010). Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect. *Developmental Psychobiology, 52*(7), 671–690. https://doi.org/10.1002/dev.20494

Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence--from domestic abuse to political terror*. Basic Books.

Hernández, A., Gallardo-Pujol, D., Pereda, N., Arntz, A., Bernstein, D. P., Gaviria, A. M., Labad, A., Valero, J., & Vilella, E. (2012). Initial validation of the Spanish Childhood Trauma Questionnaire-Short Form: Factor structure, reliability and validity. *Journal of Interpersonal Violence, 28*(7), 1498–1518. https://doi.org/10.1177/0886260512468240

Humphreys, K. L., LeMoult, J., Wear, J. G., Piersiak, H. A., Lee, A., & Gotlib, I. H. (2020). Child maltreatment and depression: A meta-analysis of studies using the Childhood Trauma Questionnaire. *Child Abuse & Neglect, 102*, 104361. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104361

Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). *Archives of General Psychiatry, 62*(6), 617–627. https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.617

Klasen, F., Gehrke, J., Metzner, F., Blotevogel, M., & Okello, J. (2013). Complex trauma symptoms in former Ugandan child soldiers. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22*(7), 698-713. https://doi.org/10.1080/10926771.2013.814741

Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D., Achenbach, T. M., Althoff, R. R., Bagby, R. M., ... & Zimmerman, M. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. *Journal of Abnormal Psychology, 126*(4), 454-477. https://doi.org/10.1037/abn0000258

Kupfer, D. J., First, M. B., & Regier, D. A. (Eds.). (2002). *A research agenda for DSM-V*. American Psychiatric Association.

Logue, M. W., van Rooij, S. J. H., Dennis, E. L., Davis, S. L., Hayes, J. P., Stevens, J. S., ... & Morey, R. A. (2018). Smaller hippocampal volume in posttraumatic stress disorder: A multisite ENIGMA-PGC study. *Biological Psychiatry, 83*(3), 244–253. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.09.006

Martín Carbonell, M., Grau Abalo, J. A., & Grau Abalo, R. (2003). El Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE): Desarrollo de una versión cubana. *Terapia Psicológica, 21*(2), 121-135.

Martín-Carbonell, M., Riquelme-Marín, A., Ortigosa-Quiles, J. M., Meda, R. M., Cerquera-Córdoba, A. M., Enríquez-Santos, J. A., & Pérez-Díaz, R. (2012). Utilidad del Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) para el diagnóstico clínico: Un estudio con muestras de cuatro países iberoamericanos. *Anales de Psicología, 28*(3), 763-771. https://doi.org/10.6018/analesps.28.3.133701

McLaughlin, K. A., Colich, N. L., Rodman, A. M., & Weissman, D. G. (2020). Mechanisms linking childhood trauma exposure and psychopathology: A transdiagnostic model of risk and resilience. *BMC Medicine, 18*(1), 96. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01561-6

Mehta, M. A., Golembo, N. I., Nosarti, C., Colvert, E., Mota, A., Williams, S. C., Rutter, M., & Sonuga-Barke, E. J. (2009). Amygdala, hippocampal and corpus callosum size following severe early institutional deprivation: The English and Romanian Adoptees Study Pilot. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50*(8), 943–951. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02084.x

O'Hare, T., & Sherrer, M. (2011). Drinking motives as mediators between PTSD symptom severity and alcohol consumption in persons with severe mental illnesses. *Addictive Behaviors, 36*(5), 465-469. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2010.12.022

Perry, B. D., Pollard, R., Blakley, T., Baker, W., & Vigilante, D. (1995). Childhood trauma, the neurobiology of adaptation, and "use-dependent" development of the brain: How "states" become "traits". *Infant Mental Health Journal, 16*(4), 271-291.

Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton & Company.

Rømer Thomsen, K., Callesen, M. B., Hesse, M., Kvamme, T. L., Pedersen, M. M., Pedersen, M. U., & Voon, V. (2018). Impulsivity traits and addiction-related behaviors in youth. *Journal of Behavioral Addictions, 7*(2), 317-330. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.22

Sansone, R. A., Leung, J. S., & Wiederman, M. W. (2012). Five forms of childhood trauma: Relationships with aggressive behavior in adulthood. *Traumatology, 19*(1), 58–63. https://doi.org/10.1177/1534765612457221

Scheeringa, M. S., & Zeanah, C. H. (2008). Reconsideration of harm's way: Onsets and comorbidity patterns of disorders in preschool children and their caregivers following Hurricane Katrina. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37*(3), 508-518. https://doi.org/10.1080/15374410802148178

Shin, S. H., Lee, S., Jeon, S.-M., & Wills, T. A. (2015). Childhood emotional abuse, negative emotion-driven impulsivity, and alcohol use in young adulthood. *Child Abuse & Neglect, 50*, 94-103. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.02.016

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Consulting Psychologists Press.

Spielberger, C. D., Buela-Casal, G., & Agudelo, D. (2008). *IDER, Inventario de Depresión Estado-Rasgo: Manual*. TEA Ediciones.

Spinazzola, J., Cook, A., Ford, J., Dumont, R., Blaustein, M., Sprague, C., ... & van der Kolk, B. (2005). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric Annals, 35*(5), 415-422.

Spinazzola, J., Ford, J. D., Zucker, M., van der Kolk, B. A., Silva, S., Smith, S. F., & Blaustein, M. (2017). Survey of exposure to objective hardships and lifetime cumulative trauma in a national sample of children and adolescents. *Journal of Traumatic Stress, 30*(5), 433-444. https://doi.org/10.1002/jts.22224

Spinazzola, J., Hodgdon, H., Liang, L.-J., Ford, J. D., Layne, C. M., Pynoos, R., ... & Kisiel, C. (2014). Unseen wounds: The contribution of psychological maltreatment to child and adolescent mental health and risk outcomes. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 6*(S1), S18–S28. https://doi.org/10.1037/a0037766

Stoltenborgh, M., van Ijzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. *Child Maltreatment, 16*(2), 79-101. https://doi.org/10.1177/1077559511403920

Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2016). Annual research review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57*(3), 241-266. https://doi.org/10.1111/jcpp.12507

van der Kolk, B. A. (2003). The neurobiology of childhood trauma and abuse. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12*(2), 293–317. https://doi.org/10.1016/s1056-4993(03)00003-8

van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.

Wolff, N., & Shi, J. (2012). Childhood and adult trauma experiences of incarcerated persons and their relationship to adult behavioral health problems and treatment. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 9*(5), 1908-1926. https://doi.org/10.3390/ijerph9051908